

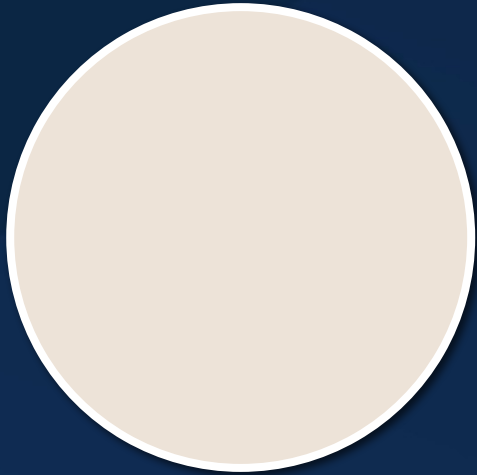
Primeros Auxilios

Brigada de primeros auxilios

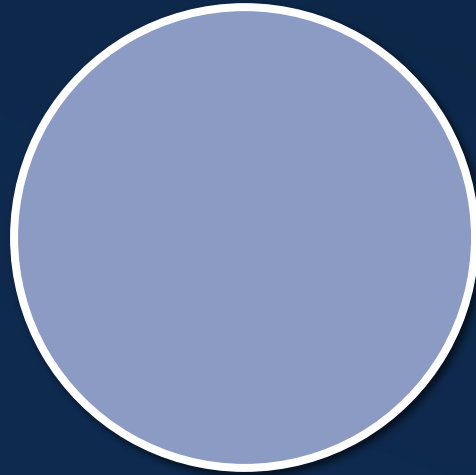
Con el apoyo de



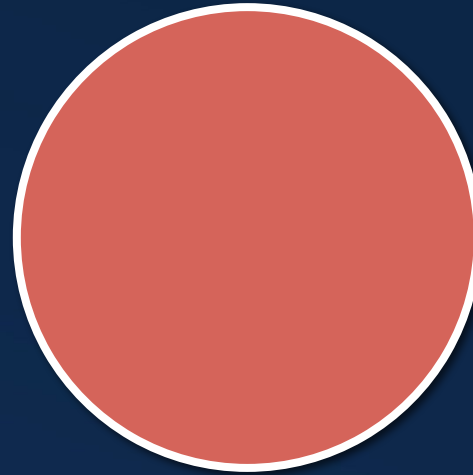
TIPOS DE COLORACION



Pálido



Cianótico



Rojizo



Ictérico

1.5.1 Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical

❑ Se debe de evaluar que la vía aérea se encuentre permeable.

❑ La causa más común de obstrucción es por que la lengua se ha relajado y está obstruyendo el paso del aire al sistema respiratorio.

COLOCACIÓN DEL COLLARÍN CERVICAL

PROTEGE LA COLUMNA, SALVA VIDAS

OBJETIVO
Inmovilizar el cuello para prevenir lesiones mayores en la columna cervical.

- 1 EVALUACIÓN INICIAL**
 - Asegura escena y verifica seguridad.
 - Valora ABCDE.
 - Sospecha lesión cervical ante trauma.
 - Inmoviliza la cabeza manualmente.
- 2 MEDIR LA ALTURA DEL CUELLO**

Mide desde la parte superior del hombro hasta la línea de la mandíbula.

PUNTO SUPERIOR
Ángulo de la mandíbula

PUNTO INFERIOR
Parte superior del hombro
- 3 SELECCIONAR EL TAMAÑO ADECUADO**

Usa la medida obtenida para elegir el collarín del tamaño correcto.
- 4 PREPARAR EL COLLARÍN**

Abre el collarín completamente y verifica que el velcro esté en buen estado.
- 5 COLOCAR EL COLLARÍN**

Desliza cuidadosamente la parte trasera del collarín por detrás del cuello del paciente.
- 6 AJUSTAR LA PARTE FRONTAL**

Cierra la parte frontal asegurando que quede centrada bajo la mandíbula y ajustada, sin oprimir.
- 7 VERIFICAR COLOCACIÓN**
 - La parte superior debe apoyar en la mandíbula.
 - La parte inferior debe apoyar en la parte superior del pecho.
 - Debe limitar el movimiento sin causar incomodidad excesiva.

TAMAÑOS ESTÁNDAR	
PEDIÁTRICO	Menos de 8 cm
PEQUEÑO	8 - 10 cm
MEDIANO	10 - 12 cm
GRANDE	12 - 14 cm
EXTRA GRANDE	Más de 14 cm

CONSEJOS IMPORTANTES

- Siempre inmoviliza la cabeza mientras se coloca el collarín.
- No retires el collarín una vez colocado.
- Reevalúa constantemente al paciente.
- Usa equipo de protección personal (EPP).

¡RECUERDA!
El collarín cervical es una herramienta vital, pero su correcta colocación hace la diferencia. Protege la columna, protege la vida.

SIEMPRE RECUERDA:
HAY CRITERIO EN SU COLOCACIÓN.
CADA PACIENTE ES DIFERENTE, CADA DECISIÓN CUENTA.

SINCAPRED

Técnicas manuales - A

TÉCNICA DE INMOVILIZACIÓN DE CABEZA
La inmovilización adecuada protege al cerebro, la médula espinal y puede salvar una vida.

¿QUÉ ES?
Es la técnica que mantiene la cabeza en posición neutra, evitando movimientos innecesarios que puedan agravar una lesión en la columna cervical.

INDICACIONES
✓ Todo paciente con trauma.
✓ Alteración del estado mental.
✓ Dolor o sensibilidad en cuello.
✓ Déficit neurológicos.
✓ Mecanismo de lesión de alto riesgo.

CONTRAINDICACIONES
✗ No hay contraindicaciones absolutas cuando se sospecha lesión cervical. La inmovilización debe realizarse siempre que haya riesgo.
⚠ La inmovilización incorrecta puede causar más daño que el movimiento ¡sé cuidadoso!

PREPARACIÓN
1. Explique al paciente lo que va a realizar.
2. Coloque a la altura de la cabeza del paciente.
3. Asigne de que haga al menos dos rescatistas para la maniobra.
4. Mantén alineado el cuerpo del paciente en todo momento.

PASOS DE LA TÉCNICA
1. POSICIÓN INICIAL
2. COLOCACIÓN DE LAS MANOS
3. MANTÉN POSICIÓN NEUTRA
4. INMOVILIZA
5. APORTE Y COMUNICACIÓN

VERIFICACIÓN DE POSICIÓN NEUTRA
La cabeza debe estar alineada con el resto del cuerpo.

DISPOSITIVOS DE INMOVILIZACIÓN
Después de mantener la posición manual, se deben utilizar dispositivos para asegurar la cabeza.

ERRORES COMUNES
✗ Permitir que la cabeza se mueva durante la evaluación.
✗ Colocar el collar cervical sin inmovilizar la cabeza.
✗ Usar fuerza excesiva o posición incorrecta de las manos.
✗ No verificar la posición neutra.
✗ Inmovilizar en posición de flexión o extensión.

RECUERDA SIEMPRE
• Trabaja en equipo y comunica cada acción.
• Comunicación constante con tu rescatista.
• Evalúa, actúa y reevalúa sin aliviar la seguridad.

ADVERTENCIAS
• Nunca sueltes la cabeza hasta que otro rescatista tome el control.
• Si hay vómito o sangrado, mantén la alineación y fíjalo con cuidado sin mover.
• Ante cualquier duda, inmoviliza. Es mejor prevenir que lamentar.

PUNTOS CLAVE
• La inmovilización de cabeza es fundamental en todo trauma.
• Mantén la cabeza en posición neutra en todo momento.
• Trabaja en equipo y comunica cada acción.
• La práctica constante hace la técnica segura y efectiva.
• Tu cuidado hoy, su vida mañana.

EDUCACIÓN
Información que transforma y salva vidas.

PREVENCIÓN
Conocimiento que reduce riesgos y protege vidas.

ACCIÓN
Actúa con calma, actúa con preparación.

¡SALVA VIDAS!
Protege a los demás, protégete a ti mismo.

EDUCACIÓN QUE PREVIENE, PREPARACIÓN QUE SALVA, ACCIÓN QUE PROTEGE.

Si se sospecha de lesión en
cuello

MANEJO BÁSICO DE LA VÍA AÉREA
ABRIR LA VÍA AÉREA ES ABRIR LA VIDA
Una vía aérea permeable es esencial para la ventilación y la oxigenación. Evalúa, actúa y reevalúa constantemente.

¿QUÉ ES?
Conjunto de maniobras y técnicas destinadas a garantizar una vía aérea permeable para lograr una ventilación adecuada.

OBJETIVOS
• Mantener una vía aérea permeable.
• Asegurar una ventilación y oxigenación efectivas.
• Prevenir la aspiración de secreciones.
• Disminuir el riesgo de obstrucción.

CAUSAS COMUNES DE OBSTRUCCIÓN
• Caída de la lengua.
• Cuerpos extraños.
• Sangre, vómitos o secreciones.
• Trauma facial o cervical.
• Edema, alergias, quemaduras.

ALGORITMO BÁSICO: EVALUAR – ABRIR – VERIFICAR – MANTENER

1. EVALUAR
Evaluación inicial rápida
• Verifica el nivel de conciencia.
• Observa y escucha la respiración.
• Busca obstrucciones visibles.
• Habla y pide permiso antes de intervenir.

2. ABRIR
Maniobras para abrir la vía aérea
• Elige la maniobra según la condición del paciente.
• Sin trauma: usar inclinación cabeza-elevación de mentón.
• Con trauma: usar tracción mandibular.

3. VERIFICAR
Confirma la efectividad
• Observa elevación del tórax.
• Escucha el paso de aire.
• Siente el flujo de aire en tu mejilla.
• Si no es efectiva, reajusta y reevalúa.

4. MANTENER
Mantén la vía aérea permeable
• Coloca al paciente en posición lateral de seguridad si está inconsciente y respira.
• Reevalúa frecuentemente.
• Aspira secreciones si cuentas con el equipo y entrenamiento.

MANIOBRAS PARA ABRIR LA VÍA AÉREA
INCLINACIÓN DE CABEZA – ELEVACIÓN DE MENTÓN
(Sin trauma)
• Coloca una mano en la frente y empuja suavemente hacia atrás.
• Con los dedos de la otra mano, eleva al mentón hacia arriba.
• No comprimes los tejidos blandos bajo el mentón.

TRACCIÓN MANDIBULAR
(Con trauma cervical sospechado)
• Coloca tus dedos dentro de los ángulos de la mandíbula.
• Eleva la mandíbula hacia adelante sin mover la cabeza.
• Mantén la boca ligeramente abierta.

POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS)
1. Coloca el brazo cercano a 90°.
2. Cruza el brazo lejano sobre el pecho y sujeta la muñeca.
3. Flexiona la pierna lejana.
4. Gira al paciente hacia ti y ajusta la posición.
Permite mantener la vía aérea abierta y reducir el riesgo de aspiración.

SEÑALES DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA
PARCIAL
• Puede hablar o toser.
• Tintidos respiratorios.
• No puede toser con fuerza.
• Anidada leve.
TOTAL
• No puede hablar, toser ni respirar.
• Se agota el cuello.
• Canelas (color azulado).
• Púrpura de la conciencia.

¿QUÉ HACER?
• Anima a toser si la obstrucción es parcial.
• Si es total y el paciente está consciente, realiza maniobras de Heimlich.
• Si está inconsciente: iniciar RCP y revisar la vía aérea.

TÉCNICA DE HEIMLICH
(Paciente consciente)
1. Párate detrás del paciente y rodea su cintura con tus brazos.
2. Coloca un puño entre el ombligo y el estómago.
3. Tira el puño con la otra mano y realiza compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.
4. Repite hasta que el objeto sea expulsado o el paciente recupere la conciencia.
5. Si queda inconsciente, inicia RCP y revierte la vía aérea.

CUÁNDO ASPIRAR
Aspira solo cuando:
• Hay secreciones visibles.
• El paciente no puede eliminárselas.
• Cuentas con el equipo y entrenamiento.
• Nunca aspiras de rutina.

EVALUACIÓN CONTINUA
• La posición del paciente puede cambiar.
• Reevalúa la vía aérea y la respiración constantemente.
• Documenta los hallazgos e intervenciones.

RECUERDA UNA VÍA AÉREA ABIERTA SALVA VIDAS.
• Evalúa siempre.
• Actúa con técnica y seguridad.
• Reevalúa constantemente.

PRINCIPIOS CLAVE
• Evalúa siempre al paciente y su entorno.
• Abre la vía aérea con la técnica correcta.
• Verifica la efectividad de la maniobra.
• Mantén la vía aérea permeable y protege al paciente.

TU INTERVENCIÓN PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.

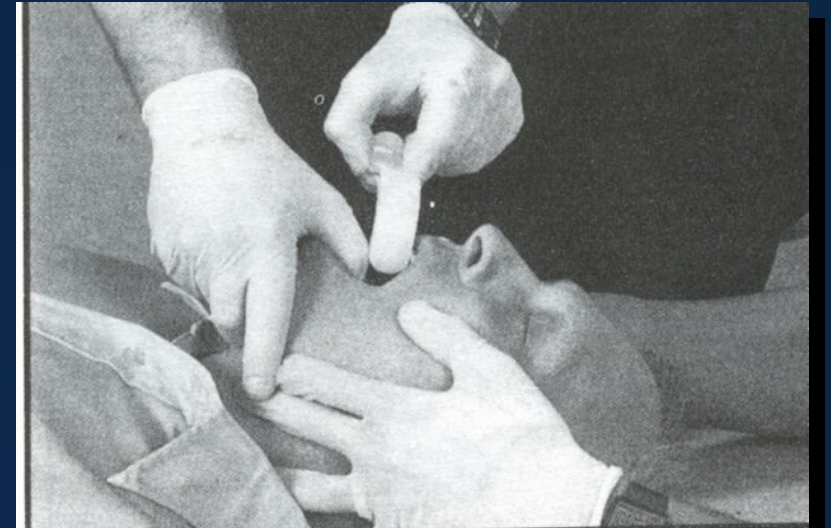
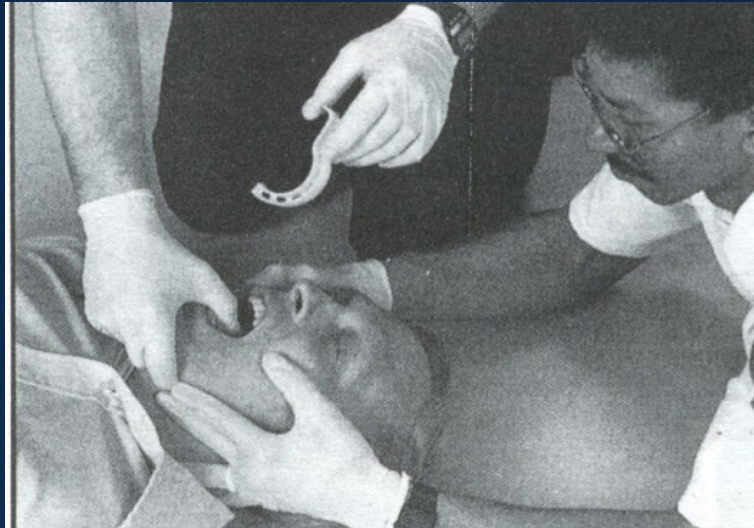
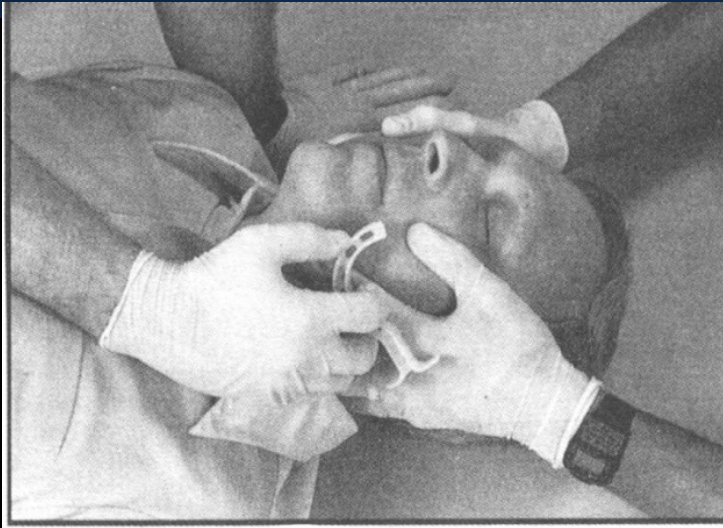
EDUCACIÓN | **PREVENCIÓN** | **ACCIÓN** | **PROTECCIÓN**

@sincapred | **@sincapred** | **@sincapredtv** | **+51 923 376 603**

Maniobra de hiper extensión de
cuello

COLOCACIÓN DE CÁNULA OROFARINGEA

A



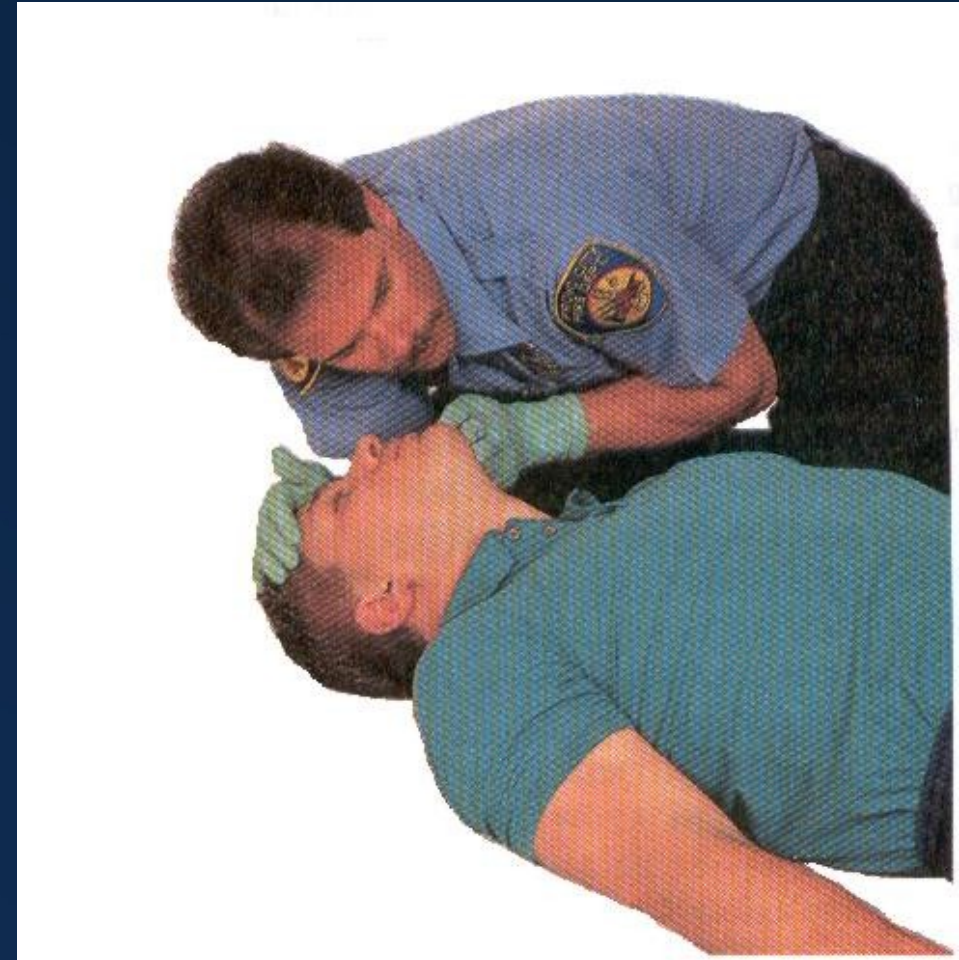
1.5.2 Buena respiración (breathing)

- ❑ Corroborar que está respirando.
- ❑ Verificar la frecuencia respiratoria.
- ❑ Observar los movimientos del tórax.

VER

ESCUCHAR

SENTIR

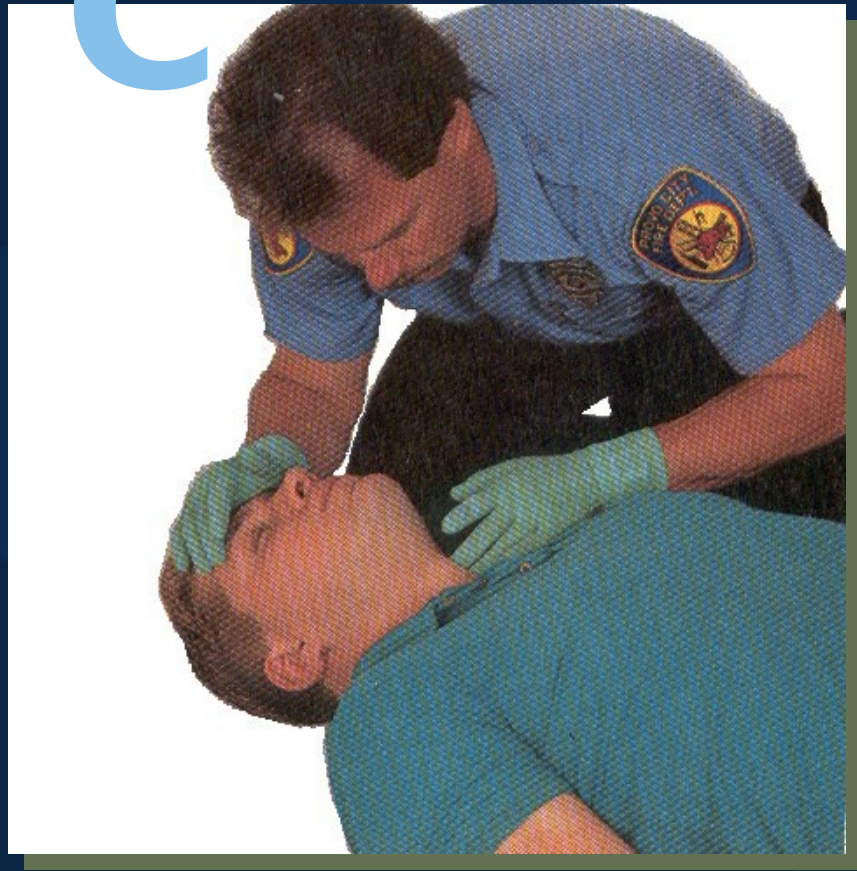


1.5.3 Circulación con control de hemorragias

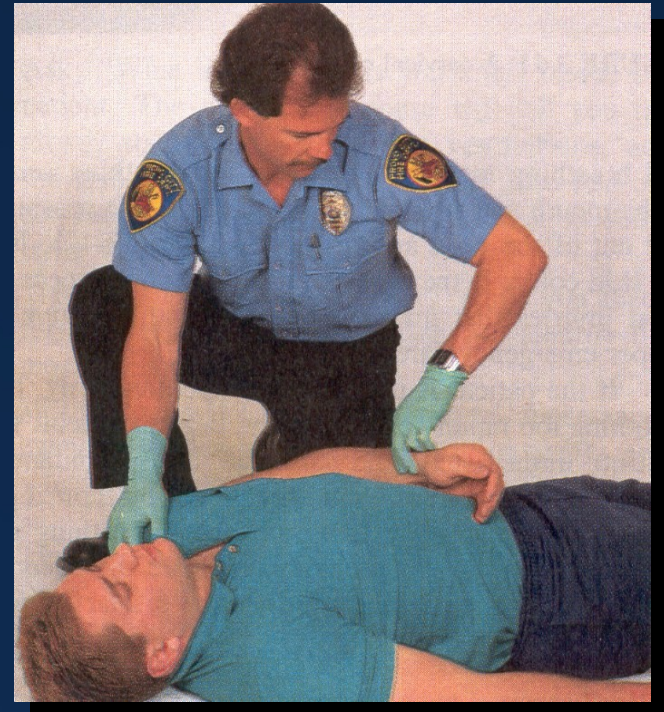
VERIFICAR PULSO

Aun que el paciente esté respirando, puede ser que el oxígeno que llega a los pulmones no esté oxigenando su cuerpo si la persona no tiene pulso.





PULSO CAROTIDEO



PULSO RADIAL

1.5.4 Déficit neurológico

- A. Alerta (responde espontáneamente a los estímulos del medio).
- V. Responde a estímulos verbales.
- D. Responde sólo a estímulos dolorosos.
- I. Inconsciente o estado de coma (no responde a ningún tipo de estímulo).



1.5.5 Exponer y examinar a la víctima protegiéndola del ambiente

Es importante exponer el tórax, el abdomen y las extremidades de los pacientes respetando su pudor. Como se podrá observar en el capítulo correspondiente, se les deberá proteger del frío, de la lluvia y del calor intenso.



1.6 Evaluación secundaria

PREsentación

Dolencia principal

Antecedentes específicos del caso

Edad

Salud anterior

Medicamentos

Alergias



UNIDAD 2. APOYO VITAL BÁSICO



2.1 Atragantamiento

DEFINICIÓN

El atragantamiento parcial o total es una emergencia que puede causar la muerte en pocos minutos si no se actúa rápido.



2.1.1 Atragantamiento parcial



Tos fuerte.

**Su voz se
escucha
aunque tosa.**

**Puede inhalar
y exhalar.**

**Sólo debe
expulsar el
objeto que le
obstruye.**

2.1.2 Atragantamiento total

CARACTERÍSTICAS.

- ❖ La persona es capaz de hablar, respirar o toser.
- ❖ La imagen muestra la postura universal de un atragantamiento total.
- ❖ Aplicar maniobra de Heimlich.

¿QUÉ HACER ANTE UN ATRAGANTAMIENTO?

Actuar con rapidez puede evitar una emergencia mayor.



- 1 SEÑALES DE ATRAGANTAMIENTO**
 - No puede hablar.
 - No puede toser.
 - Se lleva las manos al cuello.
 - Respiración difícil.
 - Coloración azulada.
- 2 SI LA PERSONA AÚN TOSA**
 - Animala a toser.
 - Mantén la calma.
 - Vigila su respiración.
- 3 SI NO PUEDE RESPIRAR**
 - Pide ayuda.
 - Llama a emergencias.
 - Aplica compresiones abdominales (maniobra de Heimlich) en adultos conscientes.
- 4 EN EMBARAZADAS O PERSONAS CON OBESIDAD**
 - Usar compresiones torácicas en lugar de abdominales.
- 5 SI PIERDE EL CONOCIMIENTO**
 - Colócala en el suelo.
 - Inicia RCP.
 - Revisa la boca solo si ves el objeto.
- 6 QUÉ NO HACER**
 - No dar agua.
 - No meter los dedos a ciegas.
 - No golpear sin control.
- 7 SEÑALES DE ALARMA**
 - Inconsciencia.
 - Piel azul.
 - Ausencia de respiración.

La prevención es clave: come despacio, en porciones pequeñas y evita hablar o reír con la boca llena.

Si no estás seguro, actúa y pide ayuda. ¡Cada segundo cuenta!

Impulsa tu perfil con el **REGISTRO INTERNACIONAL DE PARAMÉDICOS**

SOLICITA INFORMACIÓN +51 986 455 659

2.1.4 Técnica de “barrido” con el dedo (Procedimiento)

Abrir boca de
la víctima.

Detener la
lengua y
levantarla
hacia arriba.

Retirar
cualquier
objeto que
esté
obstruyendo.



2.2 Paro cardiorrespiratorio



DEFINICION.

Es la interrupción brusca, inesperada y reversible de la circulación y la respiración espontáneas.

Para revertir esta situación usted debe iniciar la re-animación cardiopulmonar mediante dos acciones: Ventilación asistida y compresiones torácicas.

$$30 \times 5 = 150 = 2 \text{ min}$$

$$30 \times 5$$
$$= 150$$
$$= 2 \text{ min}$$

Nurse Ruben **REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)** *Ruben Navarrete*

Guía visual orientativa en adulto, niño y lactante

ADULTO	NIÑO	LACTANTE
		
 Manos: 2 manos entrelazadas	 Manos: 1 o 2 manos según tamaño	 Dedos: 2 dedos (o 2 pulgares si hay 2 rescatistas)
 Frecuencia: 100–120 compresiones/min	 Frecuencia: 100–120 compresiones/min	 Frecuencia: 100–120 compresiones/min
 Profundidad: 5–6 cm	 Profundidad: ~5 cm o 1/3 del diámetro torácico	 Profundidad: ~4 cm o 1/3 del diámetro torácico
 Permitir expansión completa del tórax	 Compresiones en el centro del pecho	 Compresiones en el esternón

PUNTOS CLAVE

 Verifica respuesta y respiración.	 Llama al sistema de emergencias o pide ayuda.	 Inicia compresiones en una superficie firme.	 Contenido educativo orientativo. No sustituye entrenamiento certificado ni valoración profesional.
---	---	--	--

Nurse Ruben *Ruben Navarrete*

UNIDAD 3. HEMORRAGIAS

Concepto: *Hemorragia* es aquella pérdida de continuidad de los vasos sanguíneos que ocasiona la salida de la sangre hacia un espacio distinto al que la contiene.



SE DIVIDEN EN:



Internas

La sangre se queda
dentro del cuerpo:
no se ve



Externas

La sangre sale por
una herida: sí se ve

3.1 Clasificación de las hemorragias externas:

Arterial. Salida de sangre color rojo brillante, salida abundante y fuerte que coincide con las pulsaciones o latidos.

Venosa. Salida de sangre de color obscuro, flujo continuo y pausado.

Capilar. Hemorragia superficial con salida de sangre escasa.



3.2 Gravedad de las hemorragias



Estos son los factores que determinan la gravedad de una hemorragia.

- a) Tipo y calibre del vaso lesionado.
- b) Si la sangre fluye al interior o al exterior del organismo.
- c) Origen real de la hemorragia.
- d) Cantidad de sangre perdida.
- e) Edad y peso del paciente.
- f) Condición física y estado general del individuo.

3.3 Métodos de contención de hemorragias

- Colocar al paciente en una posición cómoda.
- Controlar la hemorragia colocando una gasa o apósito seco y limpio comprimiendo firmemente con una mano. Si se llena de sangre poner encima de este uno seco.
- Elevación del miembro afectado por arriba del corazón.

 **SINCAPRED**
ENTRENADOS PARA RESPONDER,
PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

VENDAJE ISRAELÍ

CONTROL DE HEMORRAGIAS SEVERAS

El vendaje israelí es un dispositivo de compresión de emergencia diseñado para detener hemorragias severas en extremidades de forma rápida y eficaz.

Un vendaje bien aplicado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿QUÉ ES?

Dispositivo de compresión con una almohadilla no adherente y una barra de presión que permite aplicar presión directa sobre la herida.

CARACTERÍSTICAS

- Compresión directa y uniforme.
- Barra de presión que aumenta la efectividad.
- Cierre seguro con velcro.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Reutilizable y resistente.

INDICACIONES

- Hemorragias severas en extremidades:

 - Heridas por trauma.
 - Amputaciones parciales o completas.
 - Laceraciones profundas.

- Cuando un torniquete no es posible o debe complementarse.
- En entornos tácticos, de rescate y atención prehospitalaria.

CONTRAINDICACIONES

- No usar en cuello, axilas o ingle.
- No usar como sustituto de torniquete en hemorragias que no puedan ser controladas con presión directa.
- No aflojar ni retirar para "revisar" la herida.

¿CÓMO APLICAR EL VENDAJE ISRAELÍ? (PASO A PASO)

- 1. Expón la herida**
Retira o corta la ropa alrededor de la herida para tener acceso completo.
- 2. Coloca la almohadilla**
Coloca la almohadilla no adherente directamente sobre la herida. Asegúrate de cubrirla por completo.
- 3. Envuelve**
Envuelve el vendaje firmemente alrededor de la extremidad, asegurando la almohadilla en su lugar.
- 4. Inserta la barra de presión**
Coloca la barra de presión en el dispositivo, sobre el área que tiene marcada la almohadilla.
- 5. Aplica presión**
Gira la barra de presión para aplicar presión directa sobre la herida hasta controlar el sangrado.
- 6. Asegura la barra**
Una vez detenido el sangrado, asegura la barra de presión en su lugar con los clips laterales.
- 7. Fija el vendaje**
Asegura el vendaje usando el cierre de velcro, presionando firmemente.
- 8. Verifica y registra**
Verifica que el sangrado esté controlado. Registra la hora de aplicación y monitorea al paciente.

PUNTOS CLAVE

- Aplica la presión suficiente para detener el sangrado, no más.
- No aflojes ni retires el vendaje para revisar la herida.
- Si el sangrado continúa, considera aplicar un torniquete proximal y no retires el vendaje.
- Transporta al paciente lo antes posible un centro médico.

VENTAJAS

- Permite movilizar al paciente con mayor seguridad.
- Eficaz en heridas donde el torniquete no puede aplicarse.
- Rápido de aplicar, incluso con una mano.
- Funciona en diferentes tamaños de extremidades.

COLOCACIÓN CORRECTA

CORRECTO
Sobre la herida, en la extremidad.

INCORRECTO
May cerca de la articulación.

INCORRECTO
En cuello, axilas, ingle o torso.

• El vendaje israelí es una herramienta de apoyo, no reemplaza la evaluación y tratamiento médico.
• El control de hemorragias salva vidas: actúa rápido y con decisión.
• Entrena constantemente su uso para estar preparado cuando más se necesita.

TU ACCIÓN PUEDE SALVAR UNA VIDA

PREPARACIÓN + CONOCIMIENTO + PRÁCTICA = RESPUESTA EFECTIVA

 **SINCAPRED**
ENTRENADOS PARA RESPONDER,
PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

WhatsApp
+51923376603

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

@sincapred @sincapred @sincapred

3.3 Métodos de contención de hemorragias (continuación)

- Si persiste la hemorragia ejercer presión indirecta sobre el vaso sanguíneo que se encuentre anatómicamente más cercano al sitio afectado produciendo así una disminución del flujo sanguíneo.
- Mantener al paciente en calma y tranquilo.

TORNIQUETE

USO Y RECOMENDACIONES

El torniquete es una herramienta para salvar vidas en hemorragias extremas de las extremidades que **no pueden controlarse** por otros medios.

¿CUÁNDO USARLO?	CÓMO USARLO (PASO A PASO)
Aplicar un torniquete sólo en hemorragias potencialmente mortales en extremidades cuando:  La hemorragia es severa y no se controla con presión directa.  No es posible aplicar presión directa (p. ej., por la ubicación de la herida).  Ha fallado la presión directa o el vendaje compresivo.  Usar sólo en extremidades (brazos o piernas). No aplicar en cuello, tronco, ingle ni articulaciones.	Colocar alto y apretado Colóquelo de 5-7 cm por encima de la herida, directamente sobre la piel (no sobre la articulación). Ajustar y tensar Ajuste la banda y tire con fuerza hasta que la hemorragia se detenga. Girar la varilla (windlass) Gire la varilla hasta que la hemorragia se detenga completamente. Asegurar la varilla Fije la varilla en el clip o en la banda para que no se afloje. Verificar La hemorragia debe haberse detenido y no debe haber pulso distal. Registrar el tiempo Anote claramente la hora de aplicación del torniquete en la banda o en una tarjeta.

COLOCACIÓN – ZONAS RECOMENDADAS
BRAZO Colocar en la parte alta del brazo (tercio superior), entre el hombro y el codo.
PIERNA Colocar en la parte alta del muslo (tercio superior), entre la ingle y la rodilla.

ERRORES COMUNES	PUNTOS CLAVE	¿QUÉ HACER DESPUÉS?
❌ Colocar sobre la articulación. ❌ Colocar sobre la ropa. ❌ No apretar lo suficiente. ❌ No detener completamente la hemorragia antes de asegurar la varilla. ❌ No registrar la hora de aplicación.	✅ Alto y apretado. ✅ Apretar hasta que la hemorragia se detenga. ✅ La hemorragia debe detenerse completamente. ✅ Registrar la hora de aplicación. ✅ No aflojar ni retirar el torniquete en el campo.	 Traslade al paciente al centro de atención médica lo antes posible.  No retire el torniquete.  Informe al personal de salud la hora de aplicación y el lugar de colocación.

 **EL TORNIQUETE SALVA VIDAS. USARLO CORRECTAMENTE ES ESENCIAL.**

Fuente: CoTCCC – Committee on Tactical Combat Casualty Care. TCCC Guidelines 2024. (Actualización 2024) <https://www.cotccc.org>

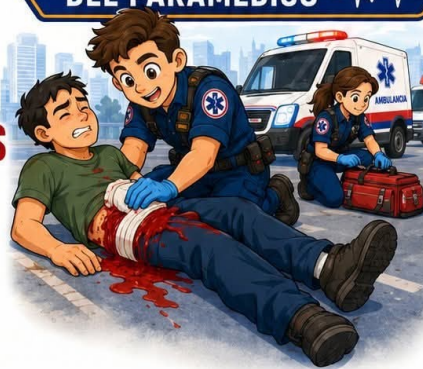
ENTRENARSE • PRACTICAR • ACTUAR RÁPIDO • SALVAR VIDAS

Control de una hemorragia externa



COLEGIO OFICIAL DE PARAMÉDICOS
Contenido educativo para salvar vidas

GUÍA RÁPIDA DEL PARAMÉDICO



MANEJO INICIAL DE HEMORRAGIAS GRAVES

Controlar el sangrado a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

1 ¿CÓMO RECONOCER UNA HEMORRAGIA GRAVE?



Sangrado abundante.



Empapa ropa o vendajes.



Piel fría o pálida.



Signos de shock.

2 ¿QUÉ HACER DE INMEDIATO?



1 Protégete con guantes.



2 Aplica presión directa sobre la herida.



3 Eleva la extremidad si es seguro.



4 Usa vendaje compresivo.



5 911
3 Activa emergencias.

3 SI NO CEDE EL SANGRADO

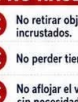
Mantén la presión directa y refuerza el vendaje.

Considera el torniquete solo si está indicado y conoces su uso.

4 QUÉ NO HACER



No retirar objetos incrustados.



No perder tiempo.



No aflojar el vendaje sin necesidad.

5 SEÑALES DE SHOCK



Pulso rápido.



Mareo o aturdimiento.



Sudor frío.



Confusión o desorientación.



Debilidad extrema.

ACTÚA RÁPIDO, ACTÚA BIEN, SALVA VIDAS.

Impulsa tu perfil con el **REGISTRO INTERNACIONAL DE PARAMÉDICOS**

Carnet acreditado Código QR verificable Reconocimiento internacional

SOLICITA INFORMACIÓN

+51 986 455 659

colegioparamedicos.org

acreditacion@colegioparamedicos.org

Guárdalo, puede ayudarte en una emergencia.

*** RESPONDER RÁPIDO PUEDE SALVAR UNA VIDA.**

Elevación de la Extremidad



Una extremidad que esta sangrando intensamente deberá elevarse por encima del nivel del corazón de la víctima, sin dejar de ejercer una presión directa o indirecta.

Presión Directa



Realizarla con un apósito, gasa estéril o lienzo limpio colocándolo sobre la herida y presionando firmemente con la palma de la mano.



4. Estado de shock

Definición

Disfunción grave y generalizada del flujo sanguíneo hacia los tejidos la cual al no ser tratada a tiempo puede desencadenar el mal funcionamiento del organismo el metabolismo y como consecuencia la muerte inminente del individuo.

Signos y síntomas

- Palidez.
- Disminución temperatura.
- Sudoración.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Respiraciones rápidas y trabajosas.
- Pulso radial débil.
- Llenado capilar mayor a 2 seg.

Choque Hipovolémico

Obedece a la pérdida de líquidos corporales por tres causas:

- +Hemorragia externa
- +Hemorragia interna
- +Deshidratación



angulomuerto_fotografia

Choque Cardiogénico

Es consecuencia de un funcionamiento inadecuado del corazón debido a padecimientos preexistentes.



SHOCK CARDIOGÉNICO

Fallo grave de la bomba cardíaca que reduce el gasto cardíaco y compromete la perfusión de los órganos vitales.

Reconocer rápido. Actuar rápido. Salvar vidas.

¿QUÉ ES?

El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón pierde su capacidad de bombear sangre de forma eficaz, provocando hipoperfusión tisular y disfunción multiorgánica. Es una emergencia médica con alta mortalidad.

CAUSAS MÁS FRECUENTES

- Infarto agudo de miocardio extenso.
- Insuficiencia cardíaca descompensada.
- Arritmias graves (bradicardia o taquiarritmias).
- Miocardiopatías agudas (miocarditis, miocardiopatía dilatada).
- Complicaciones mecánicas (rotura de músculo papilar, comunicación interventricular, taponamiento).
- Postparada cardiorrespiratoria.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Hipotensión (< 90 mmHg)
- Disminución del gasto cardíaco
- Disnea, ortopnea, edema pulmonar
- Piel fría, palida, sudoración
- Alteración del estado mental, confusión
- Oliguria (< 0.5 ml/kg/h)
- Taquicardia (frecuente)
- Náuseas, dolor torácico, fatiga

FISIOPATOLOGÍA

Disminución de la contractilidad cardíaca → ↓ Gasto cardíaco
→ Hipoperfusión tisular → Activación neurohormonal (SRAA, SNS)
→ Vasoconstricción y retención de líquidos → ↑ Pre y postcarga
→ Mayor deterioro de la función cardíaca.

Disfunción miocárdica → ↓ Gasto cardíaco → Hipoperfusión tisular → Disfunción multiorgánica

DIAGNÓSTICO

1. Evaluación clínica y antecedente de enfermedad cardíaca.
2. Electrocardiograma (ECG).
3. Ecocardiograma (disminución de la FEVI, alteraciones segmentarias).
4. Radiografía de tórax (edema pulmonar, cardiomegalia).
5. Gasometría arterial (acidosis, hipoxemia).
6. Laboratorios: Troponinas, BNP o NT-proBNP, lactato, función renal, electrolitos.
7. Monitoreo hemodinámico si está disponible.

TRATAMIENTO

1. OXIGENACIÓN
Origen para mantener SpO₂ > 94%.
Ventilación no invasiva si hay edema pulmonar.
2. OPTIMIZAR PERFUSIÓN
• Situación ventricular en bolsa pequeña y reventada.
• Evitar sobrecarga de líquidos.
3. SOPORTE INOTRÓPICO
Mejora la contractilidad y el gasto cardíaco.
• Dobutamina
• Milrinona
4. VASOPRESORES
Si persiste hipotensión a pesar del soporte inotrópico.
• Norepinefrina (de elección)
• Vasopresina
5. VASODILATADORES
Útiles si hay congestión pulmonar y presión arterial adecuada.
• Nitroglicerina
• Nitroprusiato de sodio
6. TRATAR LA CAUSA
Revascularización en IAM, control de arritmias, tratamiento de insuficiencia cardíaca, etc.
7. DISPOSITIVOS DE SOPORTE (MCA)
• Balón de contrapulsación aórtico (BCA).
• ECMO, Impella (según disponibilidad).

MONITORIZACIÓN

- ✓ Signos vitales continuos.
- ✓ SaO₂ y gasometría arterial.
- ✓ Diuresis horaria.
- ✓ Lactato sérico.
- ✓ Función renal y electrolitos.
- ✓ Presión venosa central (si está disponible).
- ✓ Respuesta al tratamiento y reevaluación constante.

ACTUACIÓN PREHOSPITALARIA

- Evaluar ABCDE y signos vitales.
- Administrar oxígeno.
- Monitorizar ECG y SpO₂.
- Acceso venoso y fluidos con precaución.
- Administrar medicación según protocolo.
- Traslado urgente a centro con UCI y cardiología.
- Comunicar hallazgos y evolución durante el traslado.

PUNTOS CLAVE

- ✓ El shock cardiogénico es una emergencia con alta mortalidad.
- ✓ La rapidez en el reconocimiento, tratamiento mejora el pronóstico.
- ✓ Trata la causa, soporte el corazón y perfunde los órganos.
- ✓ El trabajo en equipo salva vidas.

**EDUCACIÓN**
Información que transforma y salva vidas.

**PREVENCIÓN**
Conocimiento que reduce riesgos y protege vidas.

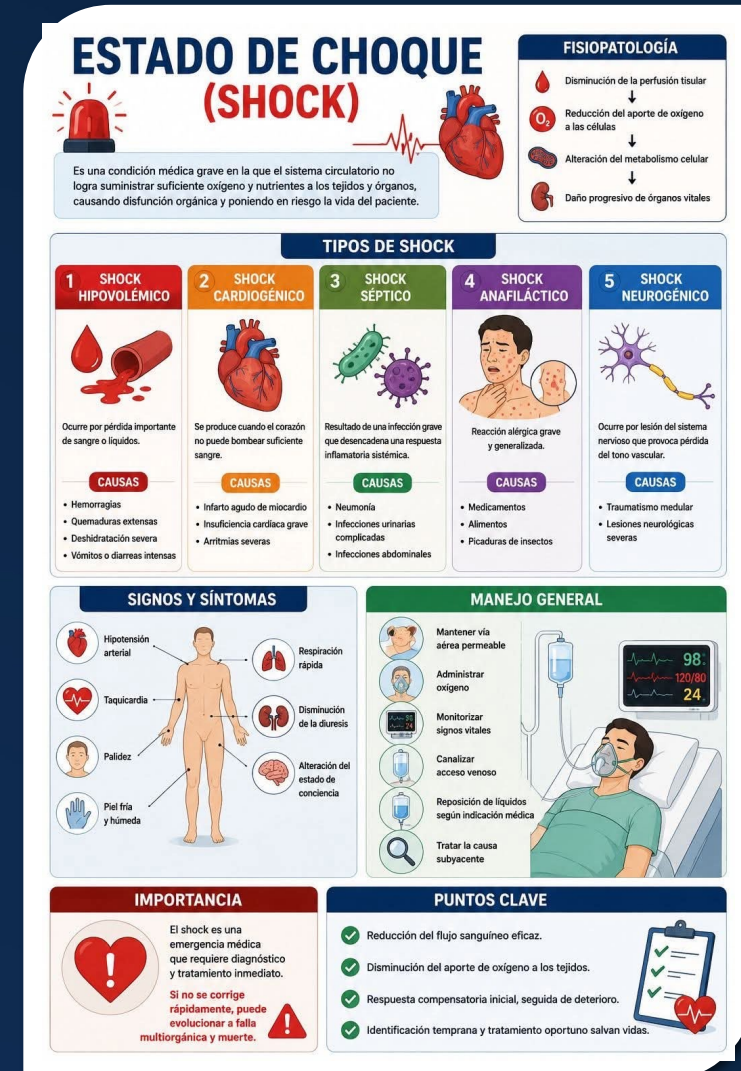
**ACCIÓN**
Actúa con calma, actúa con preparación.

**SALVA VIDAS**
Protege a los demás, protégete a ti mismo.

EDUCACIÓN QUE PREVIENE, PREPARACIÓN QUE SALVA, ACCIÓN QUE PROTEGE.

Choque Neurogénico

Lo provoca la pérdida del control del sistema nervioso cuando la médula espinal es lesionada.



Choque Anafiláctico

Se produce cuando una persona tiene contacto con alguna sustancia a la que es alérgica en extremo y provoca una reacción violenta en el organismo.

SIGNOS DE SHOCK QUE NO DEBES IGNORAR

Identificar el shock a tiempo permite actuar antes de que la situación empeore.



1 ¿QUÉ ES EL SHOCK?



Estado crítico en el que los órganos no reciben suficiente oxígeno y flujo sanguíneo.

2 SIGNOS DE ALERTA



Piel pálida o fría



Pulso rápido



Respiración acelerada



Confusión



Debilidad extrema



Sudor frío



Mareo



Pérdida de conciencia

3 ¿QUÉ HACER?

1 Llamar a emergencias.



2 Acostar al paciente.



3 Elevar piernas si es seguro.



4 Cubrir para conservar calor.



5 Vigilar respiración.



4 QUÉ NO HACER



No dar comida ni bebida.



No mover si sospechas trauma grave.



No dejar sola a la persona.

5 POSIBLES CAUSAS



Hemorragias



Infecciones



Alergias severas



Quemaduras



Impulsa tu perfil con el
**REGISTRO INTERNACIONAL
DE PARAMÉDICOS**

SOLICITA INFORMACIÓN ➔

+51 986 455 659



Choque Séptico

Ocurre en caso de infección grave, cuando las toxinas se incorporan al torrente sanguíneo afectando la circulación.

VASOPRESORES BÁSICOS

Los vasopresores son medicamentos que aumentan la presión arterial al contraer los vasos sanguíneos y, en algunos casos, mejorar la función del corazón. Se utilizan principalmente en situaciones de shock e hipotensión grave.



PRINCIPALES VASOPRESORES

 NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)	- Vasopresor de primera elección en el shock séptico. - Produce vasoconstricción potente. - Aumenta la presión arterial.	MECANISMO Estimula receptores adrenérgicos $\alpha 1$ (predomina), vasoconstricción arteriolar y venosa.	CONCENTRACIÓN HABITUAL  4 mg/250 mL SG 5% (16 mcg/mL) Dosis: 0.05 – 3 mcg/kg/min según respuesta.
 ADRENALINA (EPINEFRINA)	- Aumenta la frecuencia y fuerza cardíaca. - Utilizada en anafilaxia, paro cardíaco y shock grave.	MECANISMO Estimula receptores α y β , aumentando el gasto cardíaco, la FC y la presión arterial.	CONCENTRACIÓN HABITUAL  1 mg/250 mL SG 5% (4 mcg/mL) Dosis: 0.01 – 1 mcg/kg/min según respuesta.
 DOPAMINA	- Dependiendo de la dosis puede mejorar el gasto cardíaco o aumentar la presión arterial. - Uso más limitado actualmente.	MECANISMO Dosis bajas: dopaminérgico. Dosis medias: $\beta 1$ (aumenta gasto cardíaco). Dosis altas: $\alpha 1$ (vasoconstricción).	CONCENTRACIÓN HABITUAL  400 mg/250 mL SG 5% (1600 mcg/mL) Dosis: 2 – 20 mcg/kg/min según respuesta.
 VASOPRESINA	- Complementa la acción de otros vasopresores. - Frecuentemente asociada a la noradrenalina en shock séptico.	MECANISMO Actúa sobre receptores V_1 , provocando vasoconstricción independiente de los receptores adrenérgicos.	CONCENTRACIÓN HABITUAL  20 UI/100 mL SSN 0.9% (0.2 UI/mL) Dosis: 0.01 – 0.04 UI/min
 FENILEFRINA	- Produce vasoconstricción casi pura. - Utilizada en algunos casos de hipotensión.	MECANISMO Agonista $\alpha 1$ selectivo, produce vasoconstricción arteriolar.	CONCENTRACIÓN HABITUAL  10 mg/250 mL SG 5% (40 mcg/mL) Dosis: 0.1 – 3 mcg/kg/min según respuesta.

INDICACIONES - Shock séptico - Shock cardiogénico - Shock anafiláctico - Hipotensión severa - Paro cardíaco (algunos vasopresores)	CUIDADOS DE ENFERMERÍA  - Monitorizar signos vitales continuamente. - Vigilar presión arterial y frecuencia cardíaca. - Administrar preferentemente por vía venosa central. - Observar extravasación y cambios en la perfusión. - Registrar respuesta al tratamiento.	EFFECTOS ADVERSOS  - Taquicardia. - Arritmias. - Hipertensión. - Isquemia periférica. - Necrosis tisular por extravasación.
---	---	---

¡IMPORTANTE! Los vasopresores son medicamentos de alto riesgo y deben administrarse bajo monitorización estricta, generalmente en áreas críticas como UCI o emergencias.	 120/80 (93) 98	RECUERDA La administración segura salva vidas. Evalúa, monitoriza y documenta siempre.
--	--	--

4.1 Tratamiento de emergencia del estado de Shock

- a) Efectuar la valuación inicial.
- b) Activar el servicio médico de urgencia.
- c) Mantener una vía aérea permeable y favorecer la respiración.
- d) Controlar las hemorragias.
- e) Colocar al paciente con los pies elevados 30 cm. por arriba del nivel de la cabeza en posición que se conoce como Trendelemburg.
- f) Cubrir al paciente.
- g) Tratar de mantener consciente al paciente.
- h) Traslado rápido al hospital.



Unidad 5. Esguinces, luxaciones y fracturas



Esguince

Ruptura de los ligamentos articulares.

Luxación

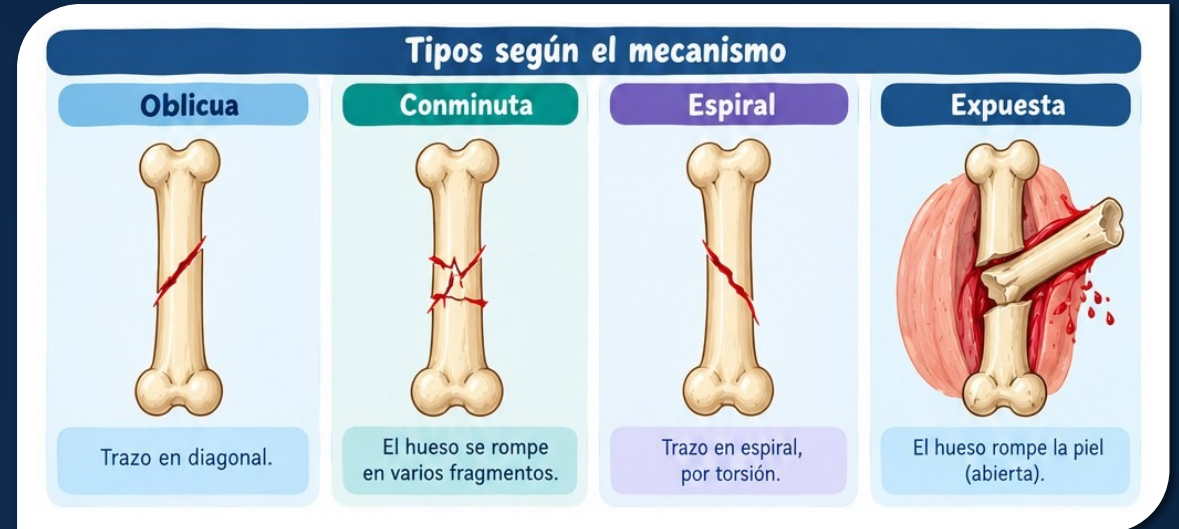
Pérdida de contacto entre los huesos de la articulación; se conoce como dislocación.

Fractura

Pérdida de la continuidad del tejido óseo.

FRACTURA:

Es la pérdida en la continuidad de un tejido óseo o hueso, incluyen huesos agrietados, astillados o completamente rotos.



Clasificación

Los métodos de clasificación de fracturas son varios, y dependen del tipo de rotura del hueso o zona corporal afectada, así como de otros factores asociados. Se pueden clasificar según su etiología en "patológicas", "traumáticas", "por fatiga de marcha o estrés" y "obstétricas".

Exposición

Dependiendo de si el punto de fractura se comunica o no con el exterior, se clasifican en:

Cerrada, si la punta de la fractura no se asocia a ruptura de la piel, o si hay herida, ésta no comunica con el exterior.

Abierta o expuesta, si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de ella, el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o el exterior.



- Deformidad de la región
 - Impotencia funcional
 - Dolor intenso y localizado
 - Crepitación ósea y hemorragia (externa en caso de ser expuesta)
 - Inflamación de la región
- 

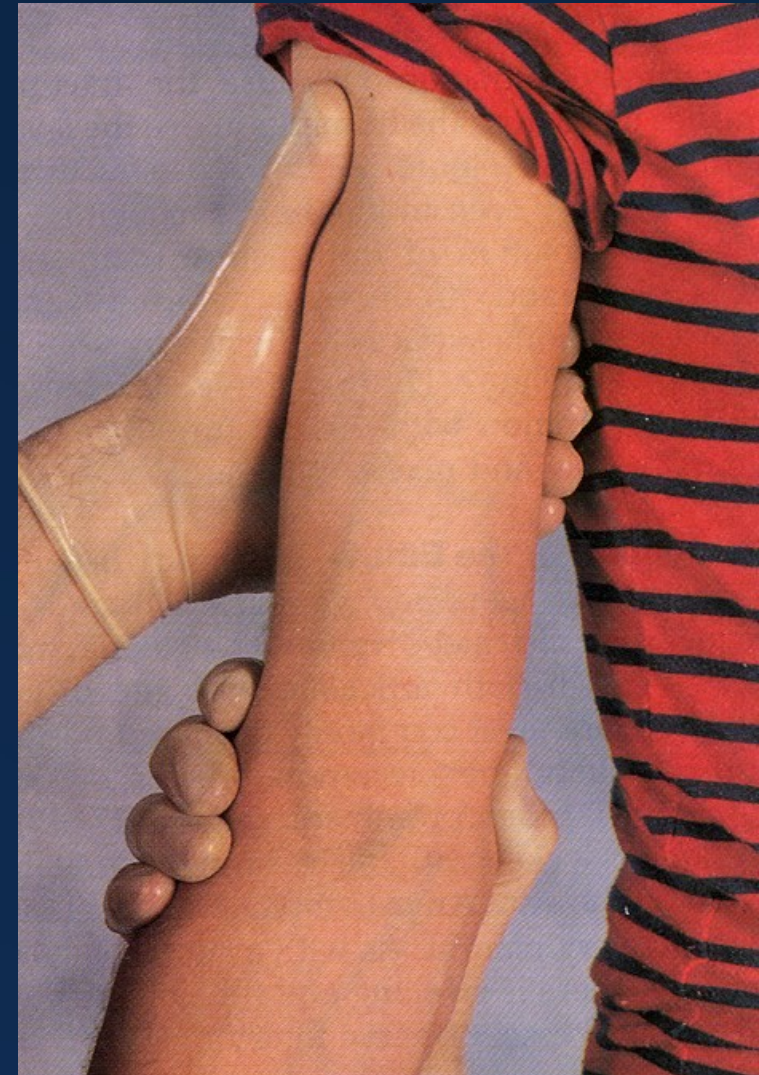
Algunas fracturas se consideran graves debido al sitio en el que se localizan por ejemplo:

- Cráneo
- Columna Vertebral
- costillas
- Pelvis



Inmovilización de fracturas

- No mover la región fracturada si no hay razón para hacerlo
- Utilizar material adecuado a la región
- Inmovilizar las dos articulaciones más próximas
- No apretar demasiado para no entorpecer la circulación



Elementos para inmovilizar

Se pueden utilizar cartones, periódicos enrollados, tablas, cobijas, etc. Estos elementos se consideran férulas, las cuales deben ser:

Cómodas

Rígidas

Seguras



Férulas

Hay varios tipos de férulas que se pueden utilizar en una emergencia:

Prefabricadas
Improvisadas
Anatómicas

 **FÉRULA SAM SPLINT**
INMOVILIZACIÓN RÁPIDA, SEGURA Y EFECTIVA

La SAM Splint es una férula moldeable y reutilizable que se adapta a cualquier extremidad.

¿QUÉ ES LA SAM SPLINT?

Es una férula flexible, ligera y resistente, compuesta por una lámina de aluminio recubierta de espuma de alta densidad.

USOS

Ideal para la inmovilización de:

- Fracturas
- Esguinces
- Luxaciones
- Lesiones en extremidades
- Estabilización en emergencias

⚠ No reemplaza la atención médica profesional. Úsala como medida temporal hasta recibir atención especializada.

CÓMO USAR LA SAM SPLINT

- 1 EVALÚA**
Evalúa la lesión y asegúrate de que no haya heridas abiertas graves.
- 2 MIDE**
Mide la férula desde la articulación por encima de la lesión hasta la articulación por debajo de la lesión.
- 3 MOLDEA**
Moldea la férula con las manos para que tome la forma de la extremidad.
- 4 COLOCA**
Coloca la férula en la extremidad, asegurándote de que quede firme y cómoda.
- 5 ASEGURA**
Asegura la férula con vendas, cintas o correas en la parte superior, media e inferior.
- 6 VERIFICA**
Verifica la circulación, sensibilidad y movimiento distal después de inmovilizar.

✓ Siempre inmoviliza la articulación por encima y por debajo de la lesión.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Muñeca, Antebrazo, Húmero, Tobillo, Pierna, Dedos

CONSEJOS DE USO

- Usa guantes al aplicar la férula.
- No aprietes demasiado las correas o vendas.
- Revisa constantemente a la persona inmovilizada.
- Combinala con vendajes para mayor seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lava con agua y jabón suave.
- Desinfecta con alcohol al 70% o solución antibacteriana.
- Deja secar completamente antes de guardar.

ALMACENAMIENTO

- Guarda en un lugar seco y fresco.
- Evita la exposición prolongada al sol.
- Puede doblarse o enrollarse para ahorrar espacio.

EDUCACIÓN
Información que transforma y salva vidas.

PREVENCIÓN
Conocimiento que reduce riesgos y protege vidas.

ACCIÓN
Actúa con calma, preparación.

SALVA VIDAS
Protege a los demás, protégete a ti mismo.

EDUCACIÓN QUE PREVIENE, PREPARACIÓN QUE SALVA, ACCIÓN QUE PROTEGE.

Complicaciones



- Hacer abierta una fractura cerrada
- Lesionar nervios, arterias y venas
- Secuelas en la movilidad
- Infección
- Trombosis grasa
- Lesionar la médula espinal
- Estado de shock

UNIDAD 6. QUEMADURAS

Una quemadura es el daño o destrucción de la piel o tejidos más profundos como el músculo y el hueso por calor o frío.

Puede darse por:

- ❑ Agentes físicos
- ❑ Agentes Químicos
- ❑ Agentes eléctricos



Quemaduras por agentes físicos

Producen quemadura por contacto directo con una fuente de calor o por calor radiante:

- Calor seco
- Calor Húmedo
- Sólidos Incandescentes
- Fricción
- Electricidad



Quemaduras químicas

Se producen por el contacto de los tejidos con sustancias químicas:

- Corrosivos
- Álcalis
- Ácidos



Signos de una quemadura

- ❖ Dolor y sensación de inflamación de la piel
- ❖ Ámpulas
- ❖ desprendimiento de la piel
- ❖ Enrojecimiento
- ❖ Hinchazón

PRIMERA RESPUESTA

Responder bien en los primeros minutos *reduce el dolor, el daño y las secuelas.*

PRIMEROS MINUTOS, MEJORES RESULTADOS

¿CÓMO RECONOCER UNA QUEMADURA TÉRMICA?

- Enrojecimiento de la piel y dolor intenso.
- Piel caliente, seca o con ampollas.
- Coloración que puede ir de rojo a blanco o negro.
- Puede ser causada por fuego, vapor, líquidos calientes o superficies.



¿CÓMO RECONOCER UNA QUEMADURA QUÍMICA?

- Enrojecimiento o palidez en la piel.
- Sensación de ardor o dolor que puede aumentar.
- Piel húmeda, resbaladiza o con manchas.
- Puede ser causada por ácidos, álcalis, solventes, cemento, entre otros.



DIFERENCIAS CLAVE

TÉRMICA			VS	QUÍMICA		
 Provocada por calor, fuego, vapor, líquidos o superficies calientes.	 El daño depende del tiempo y la temperatura.	 Puede afectar la piel y tejidos profundos (1º, 2º o 3º grado).		 Provocada por contacto con sustancias químicas corrosivas o irritantes.	 El daño continúa mientras el químico siga en la piel.	 Puede penetrar en la piel y causar daño profundo.

¿QUÉ HACER DE INMEDIATO?

TÉRMICA	QUÍMICA
- Retira a la persona del foco de calor de forma segura. - Enfría la quemadura con agua limpia a temperatura ambiente por 10-20 minutos. - No apliques hielo, pomadas ni remedios caseros. - Cubre con gasa o paño limpio y suelto. - Busca atención médica si es grave o extensa.	- Retira a la persona del área contaminada. - Quita la ropa y calzado contaminados con cuidado. - Lava la piel con abundante agua por 15-20 minutos. - No neutralices la sustancia (puede empeorar el daño). - Busca atención médica inmediata.

PREVENCIÓN EN EL TRABAJO

- Identifica y evalúa los riesgos.
- Usa EPP adecuado y en buen estado.
- Capacítate en emergencias.
- Mantén duchas y lavajos operativos.
- Almacena y etiqueta los químicos.
- Sigue los procedimientos de trabajo seguro.

¿QUÉ NO DEBES HACER?

- No uses hielo directamente.
- No revientes ampollas.
- No apliques cremas, aceites o remedios caseros.
- No frotes la zona lesionada.
- No neutralices químicos con otras sustancias.
- No dejes a la persona sola, supervisa su estado.

Actuar con rapidez y conocimiento puede salvar una vida.

Se debe a la acción de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos:

Rayos X

Rayos ultravioleta

Rayos solares



Quemadura por Electricidad

Enrojecimiento, tumefacción o carbonización

Posible pérdida del conocimiento

Posible paro cardiorespiratorio

 **COLEGIO DE PREVENICIONISTAS DE RIESGOS DEL PERÚ**

RIESGO ELÉCTRICO

La electricidad no avisa: **desenergiza, verifica y protege.**

ENERGÍA ELÉCTRICA
Un contacto puede ser fatal.

¿QUÉ ES EL RIESGO ELÉCTRICO?
Es la posibilidad de sufrir daño por contacto con la electricidad o por la ocurrencia de arcos eléctricos, que pueden causar lesiones graves, incendios, explosiones o la muerte.

- Contacto directo
- Contacto indirecto
- Arco eléctrico
- Sobrecarga

RIESGOS PRINCIPALES

- Electrocución
- Quemaduras
- Incendio
- Explosión
- Caídas por choque eléctrico
- Daño a equipos

TRABAJAR SIN CONTROL ELÉCTRICO ES EXPONER LA VIDA

ANTES DE INTERVENIR, APLICA ESTOS 6 PASOS

- Desenergiza**
Corta todas las fuentes de energía.
- Verifica ausencia de tensión**
Verifica con equipo adecuado.
- Bloquea y etiqueta**
Asegura y etiqueta todas las fuentes.
- Usa EPP dieléctrico**
Usa guantes, careta y ropa adecuada.
- Utiliza herramientas aisladas**
Usa herramientas con aislamiento.
- Señaliza y controla el área**
Delimita el área y advierte el riesgo.

ERRORES FRECUENTES

- Trabajar energizado sin control
- Usar cables dañados
- Improvisar extensiones
- Manipular con humedad

RECOMENDACIONES CLAVE

- Inspecciona instalaciones periódicamente.
- Reporta cualquier falla.
- Solo personal autorizado debe intervenir.
- Respetar distancias de seguridad.

LO ELÉCTRICO NO SE IMPROVISA
Cada verificación evita una tragedia.

Whatsapp: | Facebook: | Página web:

Quemadura de Boca Y Garganta

- ❖ Dolor en el área afectada
- ❖ Hinchazón en la zona
- ❖ Dificultad respiratoria
- ❖ Posible pérdida del conocimiento



Quemadura en Ojos

- ❖ Intenso dolor
- ❖ No tolera luz
- ❖ Párpados cerrados
- ❖ Enrojecimiento, hinchazón o lagrimeo excesivo

 **COLEGIO DE PREVENICIONISTAS DE RIESGOS DEL PERÚ**

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Ver bien y protegerse a tiempo previene lesiones permanentes.

VISION SEGURA
Tus ojos no tienen repuesto.

¿CUÁNDO DEBES PROTEGER TUS OJOS?

- 1. ESMERILADO**
Chispas y fragmentos pueden causar lesiones graves.
- 2. CORTE**
Virutas y astillas pueden impactar los ojos.
- 3. QUÍMICOS**
Salpicaduras pueden irritar o dañar la visión.
- 4. POLVO**
Partículas en el aire causan irritación y molestias.
- 5. SOLDADURA**
Radiación y chispas pueden quemar la córnea.

RIESGOS PRINCIPALES

- 1. PARTÍCULAS PROYECTADAS**
Fragmentos y objetos pueden impactar los ojos.
- 2. SALPICADURAS QUÍMICAS**
Sustancias corrosivas pueden causar lesiones severas.
- 3. RADIACIÓN UV/IR**
La radiación solar o de soldadura puede dañar la retina.
- 4. POLVO**
Irrita los ojos y puede causar infecciones.
- 5. QUEMADURAS**
Altas temperaturas pueden provocar quemaduras oculares.
- 6. VISIÓN BORROSA POR EXPOSICIÓN**
Fatiga visual y pérdida temporal o permanente de la visión.

CUIDAR TUS OJOS ES PROTEGER TU FUTURO

ANTES DE INICIAR, VERIFICA ESTOS 6 PUNTOS

- 1. ELIGE LA PROTECCIÓN CORRECTA**
Según el riesgo y la actividad.
- 2. REvisa lentes y mica**
Verifica que no tengan rayas, grietas ni opacidad.
- 3. LIMPIA LA PROTECCIÓN**
Usa paño limpio y productos adecuados. Sin rayar.
- 4. AJUSTA BIEN AL ROSTRO**
Debe quedar firme, cómoda y sin espacios.
- 5. COMBINA CON CARETA SI APLICA**
Usa careta facial para mayor protección.
- 6. REEMPLAZA SI ESTÁ DAÑADA**
No arriesgues tu visión. Reemplaza de inmediato.

ERRORES FRECUENTES

- ❌ Usar lentes rayados o con mica opaca.
- ❌ Retirarse la protección durante la tarea.
- ❌ Compartir EPP sucio o contaminado.
- ❌ Usar protección incorrecta para el riesgo.

RECOMENDACIONES CLAVE

- ✔ Mantén tu protección limpia y en buen estado.
- ✔ Guarda tus lentes en estuche cuando no los uses.
- ✔ Capacítate y capacita a tu equipo sobre su uso.
- ✔ Reporta daños o pérdida de protección.

RECUERDA

- 👁️ Una lesión ocular puede cambiar tu vida.
- 🛡️ La protección adecuada evita daños irreversibles.

Whatsapp: | Facebook: | Página web:

- ❖ Enrojecimiento de la piel, escozor
 - ❖ Hipersensibilidad
 - ❖ Piel hinchada y caliente
 - ❖ Ámpulas
- 

6.2 Lesiones sistémicas por calor



Calambre por calor:

El tratamiento:

- ✓ Quitar al paciente del ambiente caliente.
- ✓ Estirar suavemente el músculo.
- ✓ Dar masaje para fomentar circulación.
- ✓ Administrar líquidos con electrolitos como las bebidas deportivas o Vida Suero Oral.

Golpe por calor

El tratamiento:

- ✓ Enfriamiento del paciente por medio de compresas de agua tibia o fría.
- ✓ Administrar líquidos vía oral.
- ✓ Trasladar.

6.3 Lesiones cutáneas por frío

Definición: Es la congelación de tejidos corporales como consecuencia a la exposición a temperaturas muy frías.

El tratamiento:

- ✓ Colocar al paciente en un ambiente caliente.
- ✓ Colocar la parte corporal afectada sobre una superficie caliente.
- ✓ Calentar a temperatura corporal.
- ✓ Si es profunda la lesión no se recomienda el recalentamiento.
- ✓ Evitar dar masajes.



6.4 Lesiones sistémicas por frío

Hipotermia: Es la condición en la cual la temperatura interna corporal disminuye por debajo de los 35°C, afecta a individuos sanos que no estando preparados para ello y son expuestos a condiciones adversas.

Las causas:

- Permanecer al aire libre durante el invierno sin protegerse.
- Caer de una embarcación en aguas frías.
- Usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío.



Factores Que Agravan Una Quemadura



PRIMORDIALES

- Extensión
- Profundidad
- Localización

ADICIONALES

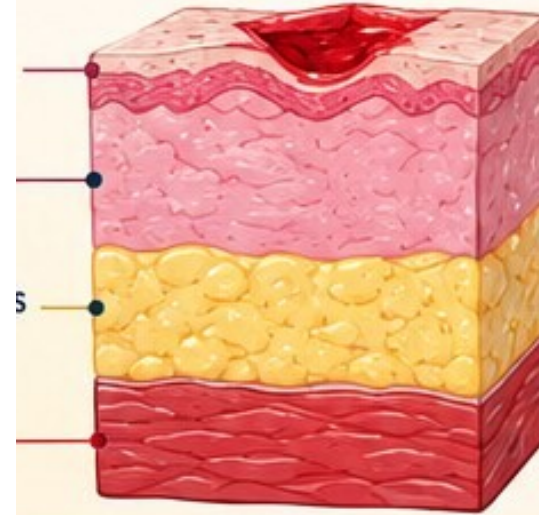
- Edad
- Sexo
- Enfermedad

Clasificación de las quemaduras

- Quemaduras 1er grado: Afectan la capa más superficial de la piel. Los síntomas son enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor intenso tipo ardor e inflamación moderada.
- Quemaduras 2do grado: afecta la segunda capa de la piel provocando ampollas, ámpulas, inflamación del área, color rosado o rojo brillante y dolor.

1er grado

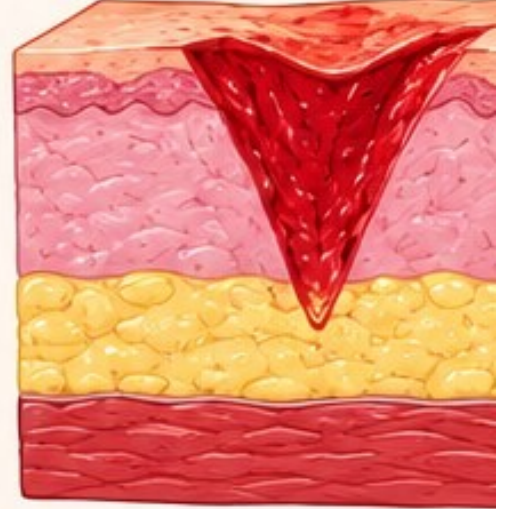
Alcanza: Epidermis



Enrojecimiento · dolor ·
hinchazón

2º grado

Alcanza: Epidermis y



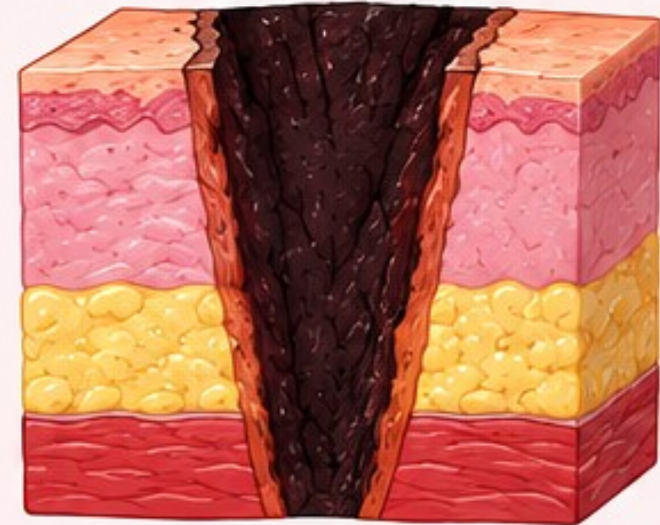
Ampollas · dolor inter
piel húmeda

Clasificación de las quemaduras (continuación)

- Quemaduras 3er grado: afecta toda la piel, músculos, tendones, nervios, hueso, se observa color blanco carbonizado, la piel pierde elasticidad y no existe dolor debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemadura se produce por contacto prolongado con elementos calientes, cáusticos o por electricidad.

3er grado

Alcanza: Todas las capas

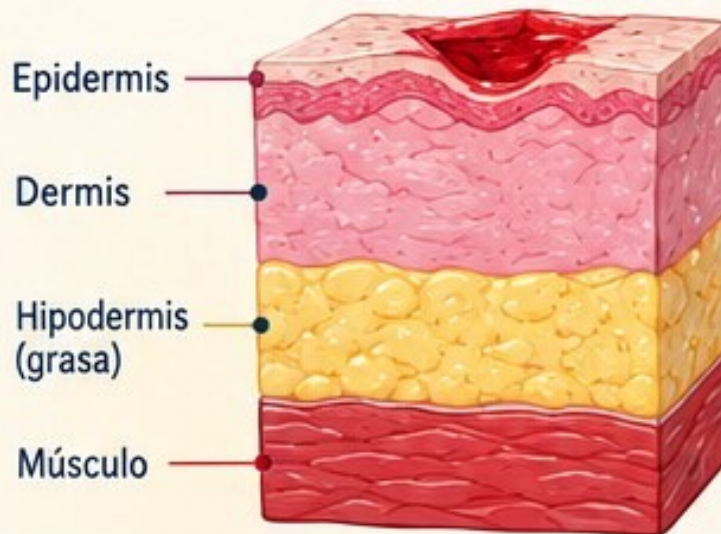


Piel blanca o carbonizada ·
sin dolor en la zona

Grados de las quemaduras

1er grado

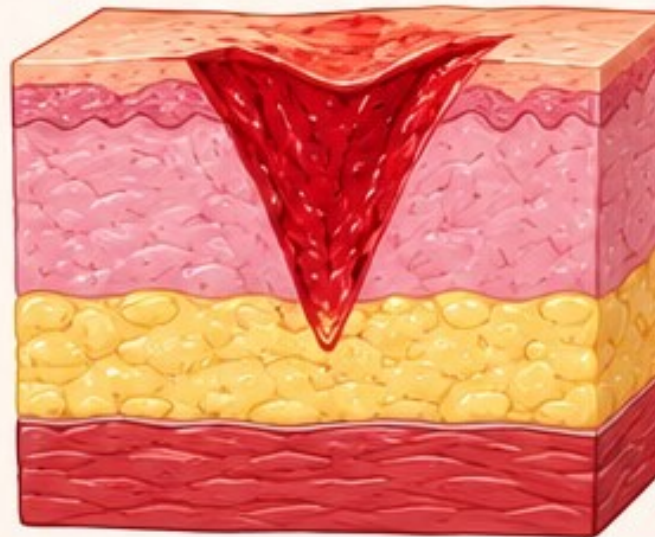
Alcanza: Epidermis



Enrojecimiento · dolor ·
hinchazón

2º grado

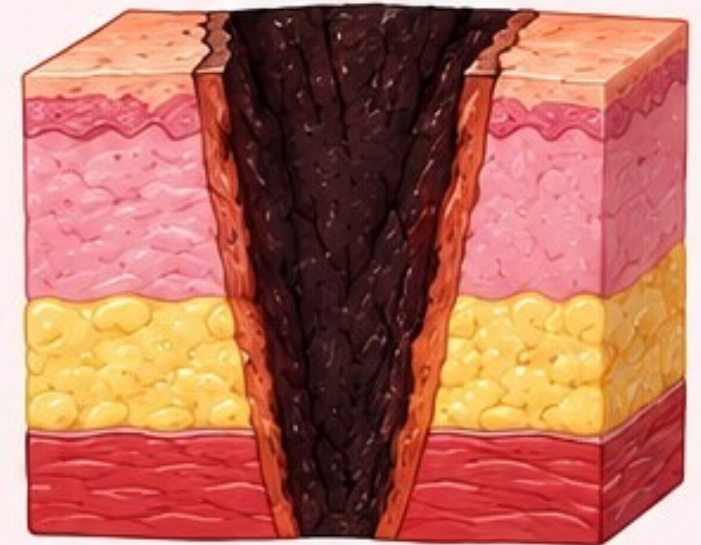
Alcanza: Epidermis y dermis



Ampollas · dolor intenso ·
piel húmeda

3er grado

Alcanza: Todas las capas



Piel blanca o carbonizada ·
sin dolor en la zona

Regla De los 9

Determina la extensión de la quemadura en un adulto

9% cabeza y cuello

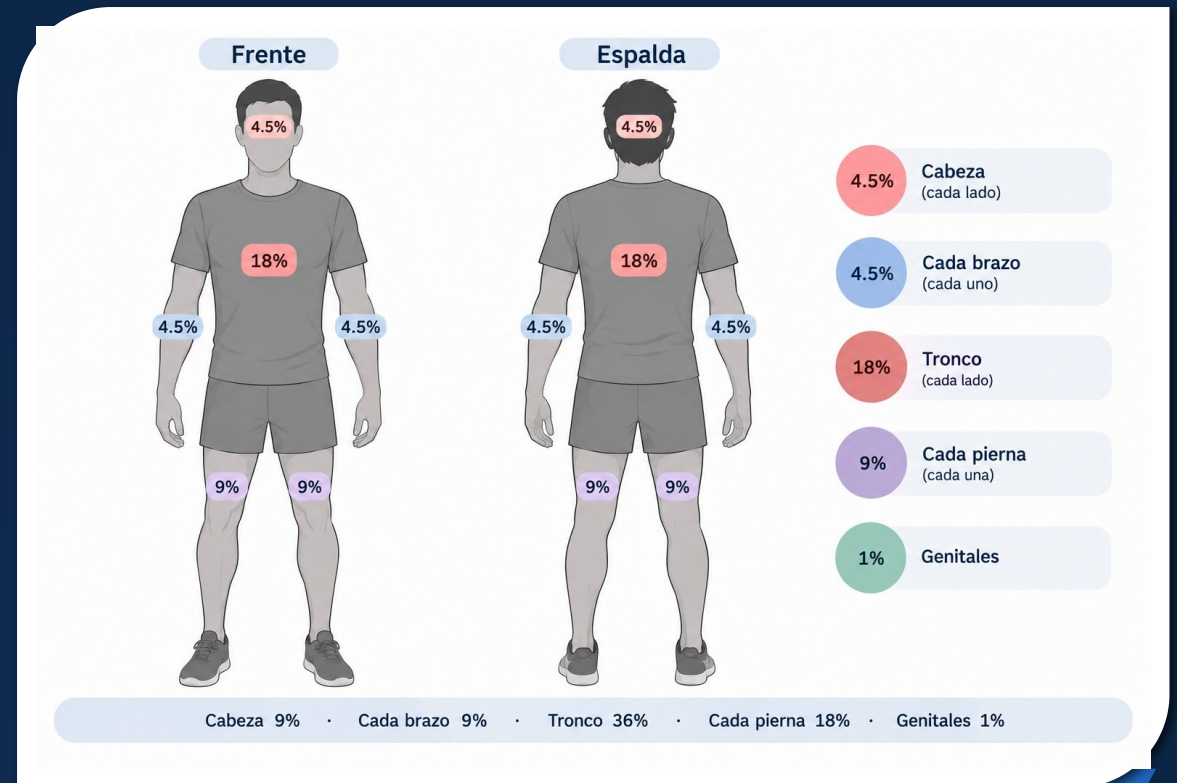
9% cada miembro torácico

18% cara anterior del tronco

18% cara posterior del tronco

18% cada miembro pélvico

1% genitales



- Aplicar agua a chorro (depende la SCQ)
 - Tranquilizar al lesionado
 - Colocar en posición cómoda
- Retirar objetos que compriman la zona
 - Retirar prendas calientes
 - Cubrir con gasas estériles (secas)
- En lesiones faciales, confeccionar una máscara

- ❖ Inmovilizar extremidades quemadas
- ❖ Prevenir estado de shock
 - ❖ Dar agua a beber
- ❖ Aplicar RCP si es necesario
- ❖ Trasladar inmediatamente a un hospital



Prohibiciones



❖ **NO:**

- ❖ Retirar nada que esté adherido
- ❖ Aplicar lociones, ungüentos ni grasa
- ❖ Romper ámpulas
- ❖ Retirar piel desprendida
- ❖ Tocar área lesionada
- ❖ Juntar piel con piel

UNIDAD 7. CONVULSIONES Y EPILEPSIA

Causas: Una convulsión se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión, enfermedad, fiebre o infección, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular.

CONVULSIÓN
ACTUAR BIEN, PUEDE SALVAR UNA VIDA

Una convulsión es una alteración temporal y súbita de la actividad eléctrica del cerebro que puede causar movimientos involuntarios, pérdida de conciencia y cambios en la respiración.

SINCAPRED
CENTRO DE FORMACIÓN EN SALUD, EMERGENCIAS Y RESCATE
FORMACIÓN QUE SALVA VIDAS

¿QUÉ PUEDE CAUSAR UNA CONVULSIÓN?

- 1. Epilepsia
- 2. Fiebre alta (convulsión febril)
- 3. Traumatismo craneoencefálico (bajo azúcar, sodio bajo, etc.)
- 4. Alteraciones metabólicas
- 5. Infecciones del sistema nervioso
- 6. Consumo o abstinencia de alcohol o drogas
- 7. Accidente cerebrovascular

TIPOS DE CONVULSIONES

GENERALIZADA
Afecta todo el cuerpo. Hay pérdida de conciencia, rigidez y movimientos involuntarios.

FOCAL (PARCIAL)
Afecta una parte del cuerpo. La persona puede estar consciente o no.

SIGNOS DURANTE LA CONVULSIÓN

- Pérdida de conciencia
- Rigidez y movimientos involuntarios
- Mirada fija
- Espuma en la boca
- Respiración irregular

¡IMPORTANTE!
La mayoría de las convulsiones terminan en 1 a 5 minutos. Permanece con la persona hasta que se recupere por completo.

¿QUÉ HACER? PRIMEROS AUXILIOS

- MANTÉN LA CALMA**
Tu tranquilidad ayuda a la persona.
- PROTEGE A LA PERSONA**
Retira objetos peligrosos alrededor.
- COLOCA EN EL SUELO**
Si está de pie o sentado, acuéstala suavemente en el suelo.
- COLOCA EN POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD**
Cuando termine la convulsión y si está inconsciente, colócala de lado.
- PROTEGE LA CABEZA**
Coloca algo suave: trapo, toallita debajo de la cabeza.
- NO RESTRINGAS SUS MOVIMIENTOS**
No sujetes a la persona ni pongas objetos en su boca.

DESPUÉS DE LA CONVULSIÓN

- La persona puede estar confundida, cansada o dormir.
- Háblale con calma y explícale lo que pasó.
- Verifica si hay lesiones.
- Ofrécele ayuda y quédate con ella hasta que se recupere completamente.

LLAMA A EMERGENCIAS (112) SI:

- La convulsión dura más de 5 minutos.
- Es la primera convulsión de la persona.
- La persona está embarazada.
- Ocurre en el agua.
- Hay dificultad para respirar después de la convulsión.
- La persona no recupera la conciencia.
- Hay lesiones graves.

NO HAGAS

- No pongas nada en su boca.
- No le des agua, comida o medicamentos.
- No la sacudas ni la sujetes.
- No la dejes sola hasta que esté completamente recuperada.

PREVENCIÓN (EN PERSONAS CON EPILEPSIA)

- Tomar los medicamentos según indicación médica.
- Dormir lo suficiente.
- Evitar alcohol y drogas.
- Evitar luces intermitentes si son desencadenantes.
- Asistir a controles médicos regulares.
- Usar identificación médica si es posible.

CONOCER, PREVENIR Y ACTUAR MARCA LA DIFERENCIA. TU ACCIÓN PUEDE SALVAR UNA VIDA.

SINCAPRED
@sincapred | @sincapred | @sincapred | +51923376603

7.1 Características de la epilepsia.

- Pérdida de conocimiento y caída al suelo.
- Contracciones involuntarias de grandes grupos musculares.
- Síntomas. La percepción subjetiva (sólo la persona las siente) de olores, colores o sonidos (olor a almendras, lucecitas, zumbidos, etc.).
- Al finalizar el enfermo entra en una especie de coma o estado estuporoso, despiertan sin recordar lo ocurrido, tienen fuertes dolores de cabeza y de todo el cuerpo, manifestando estar muy agotado.



Epilepsia · Conducta ante una crisis



- ✓ No dejar solo al paciente
- ✓ Observar las características de las crisis
- ✓ Despejar el área
- ✓ Aflojar la ropa
- ✓ Proteger la cabeza
- ✓ Colocar lo de lado
- ✓ Esperar a que la crisis termine sola

NO

✗ No introducir ningún objeto en la boca

UNIDAD 8. INTOXICACIONES Y ENVENAMIENTOS.

Intoxicación. Reacción del organismo a la entrada de un tóxico el cual puede causar lesiones o inclusive la muerte.

Veneno. Un veneno o toxina es cualquier sustancia peligrosa para el cuerpo. Es posible tragarlo, inhalarlo, inyectarlo o absorberlo a través de la piel.

SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE NUNCA DEBES MEZCLAR



MEZCLAS PELIGROSAS CON CLORO

- Cloro + Amoníaco**
Cloraminas
Esta mezcla produce gases tóxicos que pueden causar daño severo en el sistema respiratorio.
- Cloro + Alcohol en Gel**
Cloroformo
La combinación genera compuestos altamente tóxicos que representan un grave riesgo para la salud.
- Cloro + Vinagre**
Gas cloro
Libera vapores tóxicos que irritan ojos, piel y vías respiratorias.
- Cloro + Agua Caliente**
Vapores irritantes
El agua caliente aumenta la liberación de vapores de cloro, lo que puede afectar las vías respiratorias.
- Cloro + Jabón de Platos**
Gases irritantes
Puede generar vapores peligrosos dependiendo de los componentes del jabón.

MEZCLAS PELIGROSAS CON VINAGRE

- Vinagre + Agua Oxigenada**
Acido Peracético
Genera una sustancia altamente corrosiva y peligrosa para la piel, ojos y superficies.
- Vinagre + Bicarbonato**
Riesgo de presión
Produce dióxido de carbono (gas), lo que puede causar explosión si se almacena en envases cerrados.



UNIDAD 8. INTOXICACIONES Y ENVENAMIENTOS.



Síntomas

- Irritación ocular.
- Alteración del estado de conciencia.
- Falta de oxígeno.
- Nauseas, mareo y vómito.
- Convulsiones.
- Coloración azulada de los labios o quemaduras en las comisuras de la nariz y la boca.

tratamiento

- ✓ enjuagar la zona afectada con agua abundante.
- ✓ Alejar a la persona de la fuente de intoxicación.
- ✓ Quitar ropa contaminada.
- ✓ Revisar si la persona está consciente, respira y tiene pulso.
- ✓ NO inducir el vómito.
- ✓ Trasladar al hospital.



Mordedura de serpiente



En la mayoría de los casos las serpientes muerden al ser molestadas, para determinar la peligrosidad se debe tomar en cuenta la cantidad de veneno inoculado



- Taquicardia
- Vómito con sangre
- Probable ceguera transitoria
- Midriasis



- ❖ Edema
- ❖ Escalofríos
- ❖ Necrosis
- ❖ Dolor intenso
- ❖ Adormecimiento y hormigueo en la zona



Picadura de animales ponzoñosos

Signos y síntomas generales:

- Dolor intenso
- Edema
- Adormecimiento
- Contracciones musculares
- Taquicardia



- Durante los primeros minutos después de la mordedura succionar el veneno con el equipo adecuado.
 - Mantenerlo en reposo
 - Torniquete (última alternativa)
 - Traslado inmediato
- 

TRIAGE EN EL AREA DE DESASTRES



Que es un desastre?

- Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o sociedad y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Aunque frecuentemente están causados por la naturaleza, los desastres pueden deberse a la actividad humana.

 **COLEGIO DE PREVENICIONISTAS DE RIESGOS DEL PERÚ**

EVACUACION Y RUTAS DE EMERGENCIA

Salir con orden también salva vidas.

EVACUAR CON CALMA
Conocer la ruta reduce el riesgo.

¿QUÉ ES EVACUAR?

Es abandonar un lugar de forma segura y ordenada ante una emergencia para proteger la vida.

-  Moverse al punto seguro
-  Seguir rutas señalizadas
-  Actuar con orden
-  Responder a la alarma
-  Participar en simulacros

ERRORES QUE DEBES EVITAR

-  Correr o empujar
-  Usar ascensores
-  Regresar por objetos
-  Bloquear salidas
-  Desconocer el punto de reunión
-  Ignorar las brigadas

EN UNA EMERGENCIA, CADA SEGUNDO CUENTA

AL ESCUCHAR LA ALARMA, SIGUE ESTOS 6 PASOS

-  **Mantén la calma**
-  **Deja la tarea de forma segura si es posible**
-  **Sigue la ruta señalizada**
-  **No corras ni empujes**
-  **Llega al punto de reunión**
-  **Reporta tu presencia**

RECOMENDACIONES CLAVE

-  Mantén salidas libres
-  Conoce el plano
-  Participa en simulacros
-  Escucha a los brigadistas

SEÑALES IMPORTANTES

-  Salida de emergencia
-  Punto de reunión
-  Ruta de evacuación
-  Alarma

RECUERDA

 **La mejor evacuación es la que se practica.**
Prepararte hoy puede salvarte mañana.

Whatsapp: +51 910771028 | Facebook: <https://www.facebook.com/colegioprevencionistas> | Página web: www.colegioprevencionistas.com

Que es un desastre? (continuación)

- (VULNERABILIDAD + PELIGRO) /CAPACIDAD = DESASTRE
- Un desastre ocurre cuando un peligro tiene efectos en las personas vulnerables.
- Un peligro, combinado con vulnerabilidad e incapacidad para reducir sus consecuencias negativas potenciales, da lugar a un desastre.



BRIGADA DE EMERGENCIAS

PREPARADOS HOY, PROTEGIDOS SIEMPRE

¿QUÉ ES?
Es un grupo de personas organizadas, capacitadas y equipadas para prevenir, actuar y apoyar en situaciones de emergencia dentro de una empresa, institución o comunidad.

OBJETIVOS

- ✓ Proteger la vida y la integridad de las personas.
- ✓ Reducir daños a las instalaciones y al medio ambiente.
- ✓ Dar respuesta inmediata ante una emergencia.
- ✓ Apoyar a los organismos de emergencia.
- ✓ Fomentar una cultura de prevención y autoprotección.

FUNCIONES PRINCIPALES

- PREVENIR**
Identificar riesgos y promover medidas de prevención.
- ALERTAR**
Detectar la emergencia y dar la alarma oportuna.
- ACTUAR**
Controlar la emergencia con los recursos disponibles.
- APOYAR**
Brindar primeros auxilios y apoyo en la evacuación.
- EVALUAR**
Revisar las condiciones después de la emergencia y reportar.

TIPOS DE BRIGADAS

- CONTRA INCENDIOS
- PRIMEROS AUXILIOS
- EVACUACIÓN Y RESCATE
- COMUNICACIÓN Y ALERTA

¿CÓMO DEBE ESTAR CONFORMADA?

- LÍDER DE BRIGADA**
Coordina y toma decisiones.
- INTEGRANTES CAPACITADOS**
Conocimiento, actitud y compromiso.
- EQUIPO ADECUADO**
Herramientas y recursos necesarios.
- PLAN DE EMERGENCIAS**
Procedimientos claros y actualizados.
- ENTRENAMIENTO CONTINUO**
Prácticas y simulacros periódicos.

COMPROMISOS DEL BRIGADISTA

- ✓ Conocer y cumplir los procedimientos.
- ✓ Mantener la calma y actuar con seguridad.
- ✓ Cuidar su equipo y el de sus compañeros.
- ✓ Participar en capacitaciones y simulacros.
- ✓ Ser un ejemplo de prevención siempre.

RECUERDA
UNA BRIGADA BIEN PREPARADA PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA ENTRE UNA TRAGEDIA Y UNA HISTORIA DE ÉXITO.
¡EN EQUIPO, SALVAMOS VIDAS!

SINCAPRED
CENTRO DE FORMACIÓN
PREPARADOS HOY, PROTEGIDOS SIEMPRE

CONTACTO:
@sincapred
@sincapred
@sincapred
+51 923 376 603

SEGURO | **PREVENCIÓN** | **RESPUESTA** | **COMPROMISO**

Clasificación de pacientes en el área de desastres



Triaje (del francés triage = clasificación) es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

Esta clasificación, que se ha ido empleando en la guerra, se ha extendido para las catástrofes. En estas se clasifica a los pacientes por colores:

Blanco

persona fallecidas.

Negro

las posibilidades de recuperación son nulas. En algunos triages diferencian el negro que es el paciente agonizante del blanco en que ya ha fallecido.

Rojo

cuando el paciente tiene posibilidad de sobrevivir y la actuación médica debe ser inmediata.

Amarillo

pacientes que presentan una situación de urgencia con riesgo vital.

Verde

paciente levemente lesionado, que puede caminar y su traslado no precisa medio especial.

TRIAGE S.T.A.R.T Simple Triage And Rapid Treatment

¿Puede caminar el paciente?

Evaluación inicial en la escena

SI

Código verde, últimos en ser trasladados.

Moverlos a un área segura

Sirven de apoyo y para cuidar de otros pacientes

TRIAGE START
SIMPLE TRIAGE AND RAPID TREATMENT
CLASIFICACIÓN RÁPIDA PARA SALVAR MÁS VIDAS

El Triage START es un método de clasificación de pacientes en situaciones de múltiples víctimas. Permite identificar rápidamente a quienes necesitan atención inmediata, priorizando los recursos disponibles.

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

- Incidentes con múltiples víctimas
- Desastres naturales o tecnológicos
- Eventos que superen la capacidad de respuesta habitual

PRINCIPIOS DEL START

- Rápido: evaluación en menos de 60 segundos.
- Simple: sin equipos, solo observación y preguntas.
- Repetible: permite re-evaluar y reclasificar.
- Identifica a quienes pueden sobrevivir si reciben atención inmediata.

PASOS DEL TRIAGE START

- 1 RESPIRACIÓN**
¿Respira?
NO: Abrir vía aérea (maneuva frente-mentón).
SI RESPIRA: Continuar al paso 2.
NO RESPIRA: Etiqueta **NEGRO FALLECIDO**.
- 2 PERFUSIÓN**
¿Tiene pulso radial?
NO: Controlar hemorragias importantes.
SI TIENE PULSO: Continuar al paso 3.
NO TIENE PULSO: Etiqueta **ROJO INMEDIATO**.
- 3 ESTADO MENTAL**
¿Puede seguir órdenes simples?
Altra los ojos, Agriete mi mano, Mueve los pies.
NO: Etiqueta **ROJO INMEDIATO**.
SI: Continuar al paso 4.
- 4 RESPIRACIÓN**
¿Frecuencia respiratoria?
≤ 30 respiraciones/min: Etiqueta **AMARILLO DEMORADO**.
≥ 30 respiraciones/min: Etiqueta **VERDE MENOR**.

CATEGORÍAS DE PRIORIDAD

- NEGRO FALLECIDO**: Sin respiración después de abrir la vía aérea. NO RESPONDE. PRIORIDAD 1.
- ROJO INMEDIATO**: Requiere atención médica inmediata para salvar la vida. PRIORIDAD 1.
- AMARILLO DEMORADO**: Lesiones graves, pero puede esperar atención. PRIORIDAD 2.
- VERDE MENOR**: Lesiones leves, puede caminar y esperar. PRIORIDAD 3.
- AZUL NO URGENTE**: Lesiones menores, problemas administrativos. PRIORIDAD 4.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

- INMEDIATO (ROJO)**: No respira, con pulso después de controlar hemorragia.
- DEMORADO (AMARILLO)**: Respira rápido (> 30 rpm), pero puede seguir órdenes.
- MEJOR (VERDE)**: Respira normal (≤ 30 rpm), puede seguir órdenes y caminar.
- FALLECIDO (NEGRO)**: No respira después de abrir la vía aérea.

ORDEN DE EVALUACIÓN START

RE-EVALUAR: La condición del paciente puede cambiar. Re-evaluar y reclasificar siempre que sea necesario.

RECOMENDACIONES CLAVE

- Asegura tu propia seguridad antes de iniciar el triage.
- Trabaja en equipo y de manera organizada.
- Usa etiquetas o tarjetas de triage visibles.
- No te detengas en un solo paciente.
- Revisa y actualiza las prioridades según la evolución.

ETIQUETAS / TARJETAS

EN EMERGENCIAS, CADA SEGUNDO CUENTA. CLASIFICAR BIEN ES SALVAR MÁS VIDAS.

SINCAPRED
CENTRO DE FORMACIÓN EN SALUD, EMERGENCIAS Y RESCATE
FORMACIÓN QUE SALVA VIDAS

 @sincapred @sincapred @sincapred +51923376603

VENTILACION PRESENTE?



SI

NO

>30/MIN

<30/MIN

ABRIR VIA
AEREA

INMEDIATO

EVALUAR
CIRCULACION

RESPIRA
?

SI

NO

INMEDIATO



NIVEL DE CONCIENCIA



**NO obedece órdenes
simples**



INMEDIATO

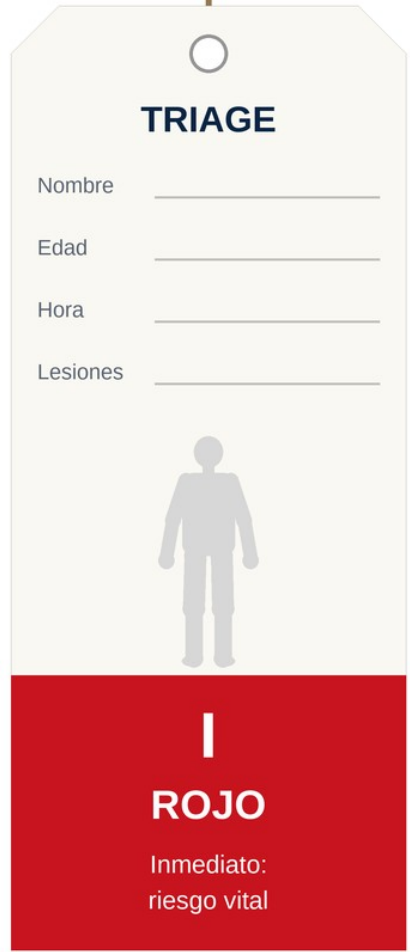
SÍ obedece órdenes simples



DEMORADO

AREA ROJOS 1a. Prioridad

- Víctimas en estado crítico recuperable.
- Tratamiento y transporte inmediato son requeridos.
- Es necesario cuidado intensivo permanente, para mantenerlas con vida.



TRIAGE

Nombre _____

Edad _____

Hora _____

Lesiones _____



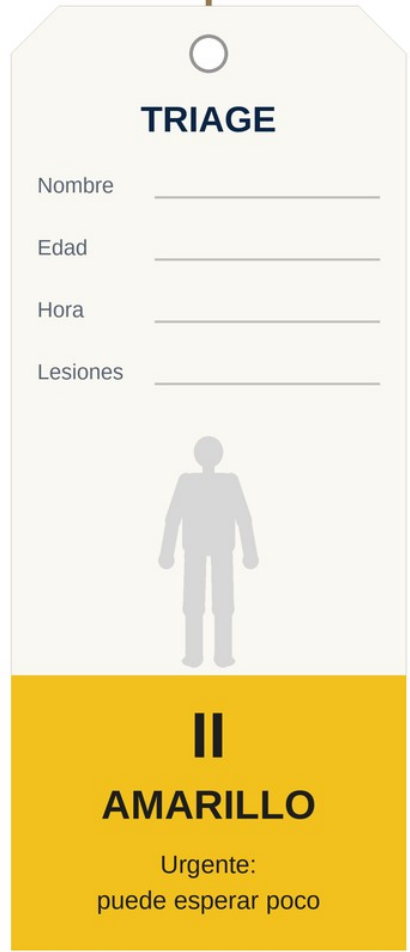
I

ROJO

Inmediato:
riesgo vital

AREA AMARILLOS 2a. Prioridad

- **Víctimas con daños moderados y severos.**
- **Transporte de urgencia es requerido, pero puede dilatarse hasta que hallan sido removidos las víctimas de 1º prioridad, es decir los del área rojos.**



TRIAGE

Nombre

Edad

Hora

Lesiones



II

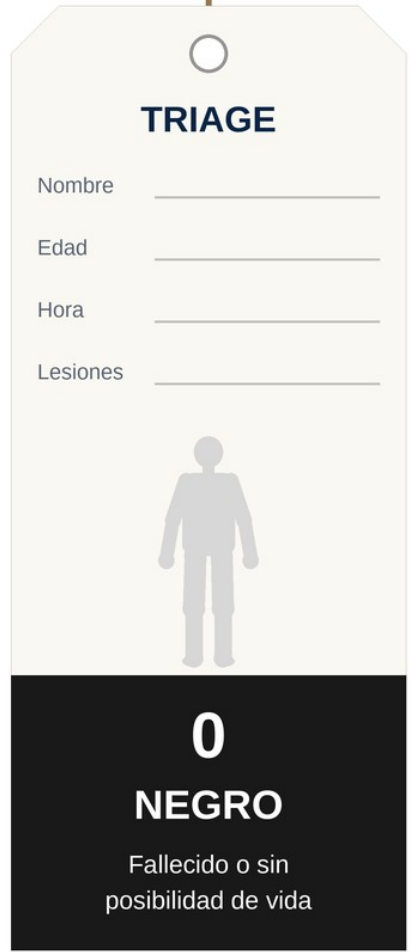
AMARILLO

Urgente:
puede esperar poco

AREA NEGROS 3a. Prioridad

Pacientes no viables, es decir sin posibilidad de sobrevida, o que no tolerarían la evacuación.

- **No requieren transporte y solo tratamiento de soporte.**
- **Esta prioridad NO SIGNIFICA “NO TRASLADAR” o “NO ASISTIRLO”, significa atención y/o traslado luego de resolver los Rojos y Amarillos, pero previo a los verdes.**
- **En la clasificación de estas víctimas, es donde se debe tener un especial cuidado y una sólida experiencia, para no cometer errores.**



TRIAGE

Nombre

Edad

Hora

Lesiones



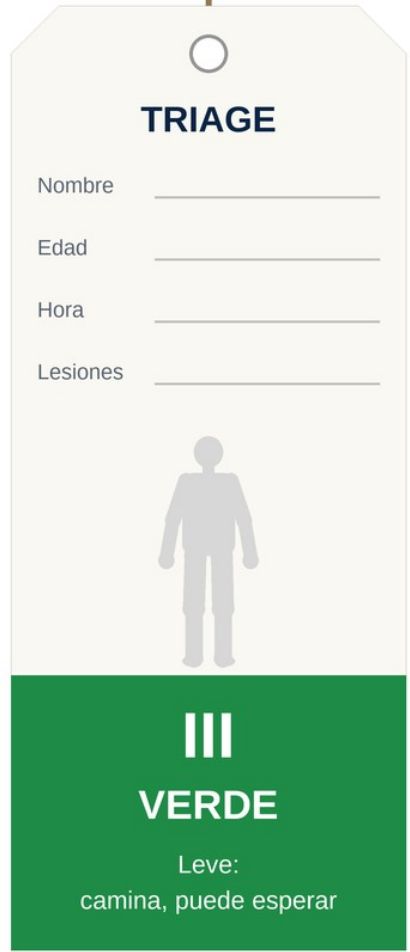
0

NEGRO

Fallecido o sin posibilidad de vida

AREA VERDES 4a. Prioridad

- **Víctimas con daños ligeros o sin daños.**
- **No es necesario transporte de urgencia, pueden ser evacuados al final, en forma masiva y en transporte no sanitario.**
- **La evaluación y el tratamiento en consultoría con el Hospital suele ser suficiente.**
- **Son lesionados, a veces asintomáticos, pero en los que se debe esperar el desarrollo de un cuadro clínico.**
- **Necesitan observación y, probablemente, tratamiento inmediato, en caso de cambiar su estado**



TRIAGE

Nombre _____

Edad _____

Hora _____

Lesiones _____

III

VERDE

Leve:
camina, puede esperar

AREA BLANCOS 5a. Prioridad

- Muertos. Son los fallecidos en el lugar. Serán depositados en un área a determinar para su identificación y actuación judicial.
 - Se deberán descontaminar y desvestir como cualquier otra víctima.
 - Deberán estar cubiertos por bolsas de bioseguridad para el transporte de cadáveres.
- 

Tarjetas de triage

0	I	II	III
NEGRO	ROJO	AMARILLO	VERDE
Fallecido o sin posibilidad de vida	Inmediato: riesgo vital	Urgente: puede esperar poco	Leve: camina, puede esperar

CONCLUSIONES

- Debido a que las lesiones sufridas en accidentes pueden afectar cualquier parte del cuerpo humano demanda que la evaluación y la atención primaria sean efectuadas de manera inteligente y eficiente, sobre las bases de individualización, previamente al transporte del lesionado.



CONCLUSIONES (continuación)



- Por lo que es esencial que el personal que brinda los primeros auxilios preste sus servicios con excelencia a fin de elevar la calidad y la capacidad de supervivencia de nuestros pacientes, actuando de forma ejemplar bajo la primicia de no producir un daño mayor al que ya sufre el paciente.



¡AGRADECIMIENTOS!



- La labor de servir a las personas en situaciones de gravedad, enfermedad o accidente es una tarea que no es fácil de ejercer, más sin embargo cuando existe la intención de aprender para ser mejor y hacer las cosas de manera correcta con el único objetivo de ayudar a los demás, para proteger lo más valioso de cada persona que es la vida misma, hace que sea una labor digna de ser admirada y agradecida.





¡AGRADECIMIENTOS! (continuación)



- ¡Gracias a ti que cada día haces la diferencia en tu entorno ayudando, colaborando para hacer de tu empresa un lugar donde todos se sientan seguros, protegidos y salvaguardados!
- 
- 

¡Gracias!

Brigada de primeros auxilios



Con el apoyo de

